



RUMAH SAKIT  
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA  
KOMITE PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN INFEKSI**

**BULAN APRIL  
TAHUN 2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

[www.rs-primahusada.com](http://www.rs-primahusada.com)

---

**LAPORAN KINERJA KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)  
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO  
TAHUN 2025**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Umum/Latar belakang**

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Disisi lain, rumah sakit menjadi mata rantai transmisi penyakit. Penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan atau *Healthcare Associated Infections* (HAIs) merupakan salah satu masalah kesehatan di berbagai nega di dunia, termasuk Indonesia. Dalam forum *Asian Pasific Economic Comitte* (APEC) atau *Global Health Security Agenda* (GHSA) penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan telah menjadi agenda yang dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa HAIs yang ditimbulkan berdampak secara langsung sebagai beban ekonomi negara.

Secara prinsip, kejadian HAIs sebenarnya dapat dicegah bila fasilitas pelayanan kesehatan secara konsisten melaksanakan program PPI. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi merupakan upaya untuk memastikan perlindungan kepada setiap orang terhadap kemungkinan tertular infeksi dari sumber masyarakat umum dan disaat menerima pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pelayanan kesehatan, perawatan pasien tidak hanya dilayani di rumah sakit saja tetapi juga di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, bahkan di rumah (*home care*).

**1.2. Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 449.5/RSPHS/I-PER/DIR/III/2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

**1.3. Maksud dan Tujuan**

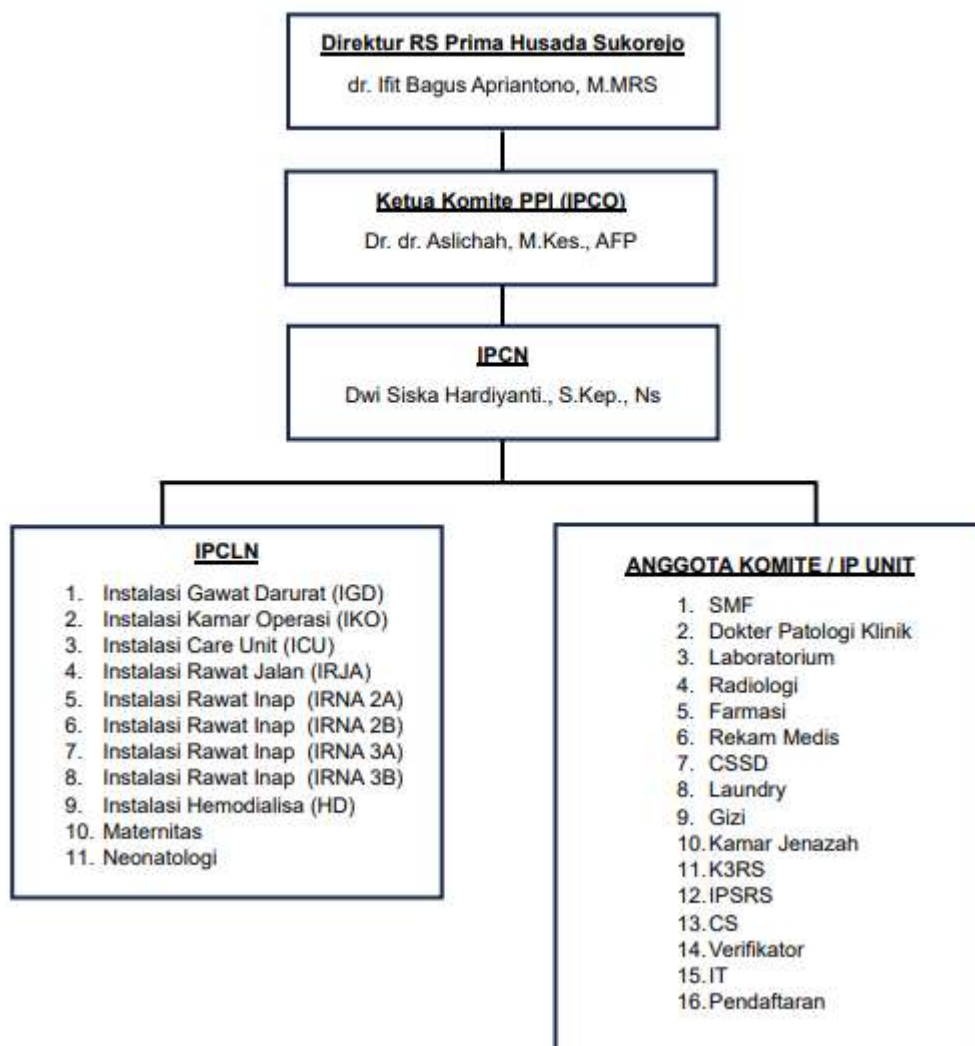
Sebagai panduan untuk pencapaian visi dan misi RS Prima Husada Sukorejo dalam mencapai tujuan organisasi yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan professional melalui penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, sehingga setiap individu dapat bekerja secara sistematis dan terstruktur.

## BAB II GAMBARAN UMUM

- 2.1 Visi  
Menjadikan rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan Masyarakat
- 2.2 Misi
1. Memberikan pelayanan Kesehatan dengan aman, cepat, tepat, dan akurat.
  2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien
  3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan
- 2.3 Motto  
***“Clean Hands, Save Lives”***
- 2.4 7 Nilai Budi Utama
1. Jujur
  2. Tanggung jawab
  3. Dipercaya
  4. Visioner
  5. Kerjasama
  6. Adil
  7. Peduli
- 2.5 SOTK

Gambar 1. SOTK Komite PPI 2025

### **SOTK KOMITE PPI**



BAB III.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

- 3.1 SDM :
- 3.1.1 Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi dan kebutuhan)

| Jabatan | Analisis<br>Beban<br>Kerja | Jumlah SDM |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Kebutuhan | Ket.                                                    |
|---------|----------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------|---------------------------------------------------------|
|         |                            | Bulan Ke-  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |                                                         |
|         |                            | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |           |                                                         |
| IPCO    | 1                          | 1          | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |    |    |    | 1         | Peremenkes<br>No 27 tahun<br>2017<br>1 IPCN =<br>100 TT |
| IPCD    | 1                          | -          | - | - | - |   |   |   |   |   |    |    |    | 1         |                                                         |
| IPCN    | 1                          | 1          | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |    |    |    | 1-2       |                                                         |

- 3.1.2 Orientasi
- Tabel 3.1.2. Pelaksanaan Orientasi PPI bagi Karyawan baru RSPH Pasuruan Tahun 2025

| No    | Bulan    | Jumlah Peserta                                          | Pelaksanaan | Hasil Evaluasi orientasi |
|-------|----------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1.    | Januari  | Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Januari 2025  |             |                          |
| 2.    | Februari | Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Februari 2025 |             |                          |
| 3.    | Maret    | Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Maret 2025    |             |                          |
| 4.    | April    | Tidak ada orientasi staff baru pada bulan April 2025    |             |                          |
| 5.    | Mei      |                                                         |             |                          |
| Total |          |                                                         |             |                          |



Tabel 3.1.4.2 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Bulanan

[illegible]









[illegible]



Tabel 3.1.4.8 Hasil Penilaian PIC PPI Unit Bulan April 2025

| UNIT           | SURVEILANS | LAPBUL | EDUKASI | AUDIT HH | AUDIT APD | AUDIT PROGRAM | NILAI |
|----------------|------------|--------|---------|----------|-----------|---------------|-------|
| ICU            | 100        | 80     | 100     | 90       | 95        | 0             | 78    |
| IGD            | 91         | 80     | 75      | 90       | 90        | 0             | 71    |
| IKO            | 40         | 60     | 0       | 38       | 30        | 0             | 28    |
| IRJA           | 80         | 70     | 38      | 75       | 45        | 0             | 51    |
| IRNA 2A        | 100        | 80     | 75      | 100      | 85        | 0             | 73    |
| IRNA 2B        | 90         | 80     | 88      | 90       | 85        | 0             | 72    |
| IRNA 3A        | 95         | 80     | 100     | 90       | 90        | 0             | 76    |
| IRNA 3B        | 90         | 76     | 88      | 75       | 80        | 0             | 68    |
| MATER          | 95         | 80     | 100     | 95       | 95        | 0             | 78    |
| NEONATOLOGI    | 100        | 80     | 100     | 95       | 95        | 0             | 78    |
| GIZI & DAPUR   | 0          | 80     | 0       | 95       | 85        | 0             | 43    |
| FARMASI        | 0          | 70     | 0       | 65       | 65        | 0             | 33    |
| LAB            | 0          | 80     | 0       | 90       | 90        | 0             | 43    |
| RM & PDF       | 0          | 63     | 50      | 0        | 0         | 0             | 19    |
| RADIOLOGI      | 0          | 63     | 13      | 35       | 35        | 0             | 24    |
| CSSD & LAUNDRY | 0          | 0      | 0       | 0        | 0         | 0             | 0     |

Tabel 3.1.4.9 Analisa dan Tindak Lanjut Penilaian Kinerja PIC PPI Unit 2025

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analisa               | <p>Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi penilaian kinerja staf IPCLN dan PIC PPI bulan April tahun 2025 dengan penugasan sebagai berikut,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaporan surveilans</li> <li>Pelaporan dan penginputan laporan <i>by link</i></li> <li>Pemberian edukasi kelompok dan individu dengan sasaran pasien, pengunjung serta staf unit</li> <li>Pelaporan audit HH</li> <li>Pelaporan audit APD</li> <li>Pelaporan audit program</li> </ol> <p>Dapat diketahui bahwa pelaporan belum berjalan secara maksimal, dan masih ditemukan beberapa unit yang tidak patuh dalam melakukan pelaporan secara <i>real time</i>. Adapaun unit dengan skoring tertinggi dan menjadi PIC teladan pada bulan April tahun 2025 yakni ICU, Maternitas dan Neonatologi dengan skor 78.</p> |
| Rencana Tindak Lanjut | <ol style="list-style-type: none"> <li>Berikan penilaian kinerja setiap bulan pada saat melakukan rapat koordinasi komite PPI</li> <li>Lakukan koordinasi dengan SDM dan berikan reward kepada unit teladan setiap bulannya</li> <li>Lakukan koordinasi dengan Kabid terkait hasil temuan-temuan setiap bulannya</li> <li>Lakukan perbaikan dengan IPCO setiap kali melakukan agenda rapat dalam pembahasan temuan-temuan serta kendala pada masing-masing unit</li> <li>Berikan motivasi kepada semua PIC PPI unit yang baik yang sudah dan belum maksimal dalam melakukan penugasan serta evaluasi secara bersama dengan IPCO</li> <li>Lakukan koordinasi dengan Kabid serta SDM terkait kepatuhan unit dan staff dalam proses menjadi seorang PIC PPI di unit</li> </ol>                                |

### 3.2 Hasil Pengembangan Pelayanan

Tabel 3.2.1 Pengembangan Pelayanan

| No | Kegiatan  | Bulan                 | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Analisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pelatihan | Januari               | Tidak ada staff yang melakukan pelatihan internal atau eksternal di bulan Januari 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2  | Pelatihan | Februari              | Tidak ada staff yang melakukan pelatihan internal atau eksternal di bulan Februari 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | Pelatihan | Maret<br>(22/03/2025) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IDO (Infeksi daerah operasi) bisa di sebabkan oleh faktor endogen (usia, penyakit penyerta, jenis kelamin, pola hidup) dan eksogen (tipe dan lama operasi, keahlian tim bedah, pemilahan operasi, pemasangan impaln, sterilisasi instrumen bedah, kualitas ruang op, kualitas fasilitas/peralatan yang ada di ruang operasi)</li> <li>2. 4 klasifikasi luka IDO <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luka bersih 1-2%</li> <li>2) Bersih terkontaminasi 6-9%</li> <li>3) Luka terkontaminasi 13-20%</li> <li>4) Luka kotor 40%</li> </ol> </li> <li>3. Pemberian profilaksis di lakukan 1 jam sebelum insisi dan sesegera mungkin sebelum dilakukan pembedahan</li> <li>4. Pemberian profilaksis harus berbeda dengan terapi AB yang digunakan pasien selama proses rawat inap</li> <li>5. Dikatakan IDO ketika <ol style="list-style-type: none"> <li>1) post op hari ke 30-90 yang disertai dengan demam, kemerahan, bengkak, keluar pus</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya SPO pembersihan ruang IKO yang ter-update</li> <li>2. Tidak patuh dan rutinnya jadwal bongkaran di ruang IKO</li> <li>3. Tidak patuhnya staff IKO dalam melakukan tatalaksana ruang operasi sesuai dengan prosedur</li> <li>4. Penerapan bundle IDO di RS belum berjalan sesuai dengan standart</li> <li>5. Jadwal pemberian profilaksis (antibiotik) di setiap unit masih belum berjalan maksimal 60 menit sebelum jam insisi</li> <li>6. Masih ditemukan alat di ruang IKO tidak terpusat di CSSD dalam proses pembersihan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan SPO pembersihan ruang IKO</li> <li>2. Pembuatan jadwal bongkaran IKO</li> <li>3. Sosialisasi dan re-edukasi kepatuhan petugas dalam melaksanakan tatalaksana ruang operasi</li> <li>4. Penerapan bundle IDO oleh unit IKO dan all unit rawat inap serta rawat jalan</li> <li>5. Edukasi pemberian profilaksis (antibiotik) harus 60 menit sebelum insisi</li> <li>6. CSSD melakukan pendaataan dan edukasi ulang terkait instrumen yang ada di IKO wajib dilakukan pembersihan dan sterilisasi di CSSD</li> </ol> |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>2) golden period terjadi pada hari ke 0-30 hari</li><li>6. Dampak IDO<ul style="list-style-type: none"><li>1) memperpanjang masa rawat, sering re-admisi, kebutuhan ICU</li><li>2) mortalitas meningkat</li><li>3) disabilitas permanen</li><li>4) prosedur bedah tambahan</li><li>5) kontribusi pada peningkatan resistensi antibiotik</li></ul></li><li>7. Teknik penerapan IDO<ul style="list-style-type: none"><li>1) Pre operatif : mandi dengan clorhexidin sehari sebelum op dan hari H ketika proses pembedahan, pencukuran menggunakan cleaper (dilakukan di RS supaya terkontrol oleh petugas tekniknya), pemberian antibiotik kurang dari 120 menit</li><li>2) Intra operatif : pemberian O2, pemantauan suhu tubuh, pemantauan gula darah</li></ul></li><li>8. Bongkaran/pembersihan IKO<ul style="list-style-type: none"><li>1) pembersihan harian (dilakukan selama prosedur op telah selesai semua)</li><li>2) bongkaran 1 minggu sekali (dilakukan secara rutin dan terjadwal)</li><li>3) bongkaran 1 bulan sekali</li><li>4) pembersihan pasca renovasi</li></ul></li><li>9. Pembersihan lingkungan</li></ul> |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>1) terdapat SPO tersendiri dalam pembersihan ruang khusus (iko)</li><li>2) melakukan pemeriksaan lingkungan secara rutin (6 bulan sekali)</li></ul> <p>10. kualitas ruang operasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) pintu otomatis</li><li>2) tempat cuci tangan menggunakan sensor</li></ul> <p>11. alur instalasi ruang bedah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) zona luar : koridor masuk, area transfer, nurse station, area dokumentasi, preoperasi, area ganti baju</li><li>2) zona bersih : koridor bersih, ruang simpan alat steril, ruang anastesi dan RR, area istirahat</li><li>3) zona retriksi : scrub sinks, ruang operasi</li></ul> <p>12. persiapan alat/instrumen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) alat "non kritis"</li><li>2) alat "semi kritis"</li><li>3) alat "kritis"</li></ul> <p>13. prinsip rawat luka pasien post op</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) assesmen komprehensif luka dan pasien</li><li>2) pengendalian infeksi</li><li>3) pemilihan dressing yang tepat</li><li>4) manajemen nyeri</li><li>5) pendidikan pasien dan keluarga</li></ul> <p>14. tata kelola kamar operasi</p> |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <ol style="list-style-type: none"><li>1) penjadwalan operasi :<br/>mengatur (mengatur kamar operasi, operator dna tim operasi, durasi op)</li><li>2) persiapan pasien</li><li>3) koordinasi tim medis</li><li>4) pengurangan waktu tunggu</li><li>5) alur pasien yang efisien</li></ol> <p>15. manajemen linen</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) penanganan linen di kamar op harus sesuai</li><li>2) pemisahan linen kotor terkontaminasi darah atau cairan tubuh dengan linen kotor tidak terkontaminasi</li><li>3) tidak menempatkan linen di lantai</li><li>4) semua linen infeksius dimasukkan ke dalamkantong dengan kode infeksius</li><li>5) linen yang terkontaminas cairan tubuh dibersihkan sebelum proses selanjutnya</li></ol> <p>16. manajemen limbah</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pisahkan limbah sesuai dengan jenisnya</li><li>2) tempatkan limbah sesuai dengan jenisnya</li></ol> <p>17. sterilisasi dan perawatan peralatan medis</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) sterilisasi alat bedah</li><li>2) desinfeksi permukaan</li><li>3) penyimpanan yang tepat</li><li>4) pemeliharaan yang rutin</li></ol> |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|





|   |           |            |                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|---|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   |           |            | 18. semua peralatan/instrumen bedah wajib di lakukan sterilisasi di CSSD<br>19. ruang/gedung kamar operasi : boleh sampai dengan lt. 4 dengan memperhatikan struktur dan arah cahaya dari bangunan |  |  |
| 4 | Pelatihan | April 2025 | Tidak ada staff yang melakukan pelatihan internal atau eksternal di bulan April 2025                                                                                                               |  |  |
| 5 |           | Mei 2025   |                                                                                                                                                                                                    |  |  |

[illegible]

[illegible]

b. Kewaspadaan Isolasi

[illegible]

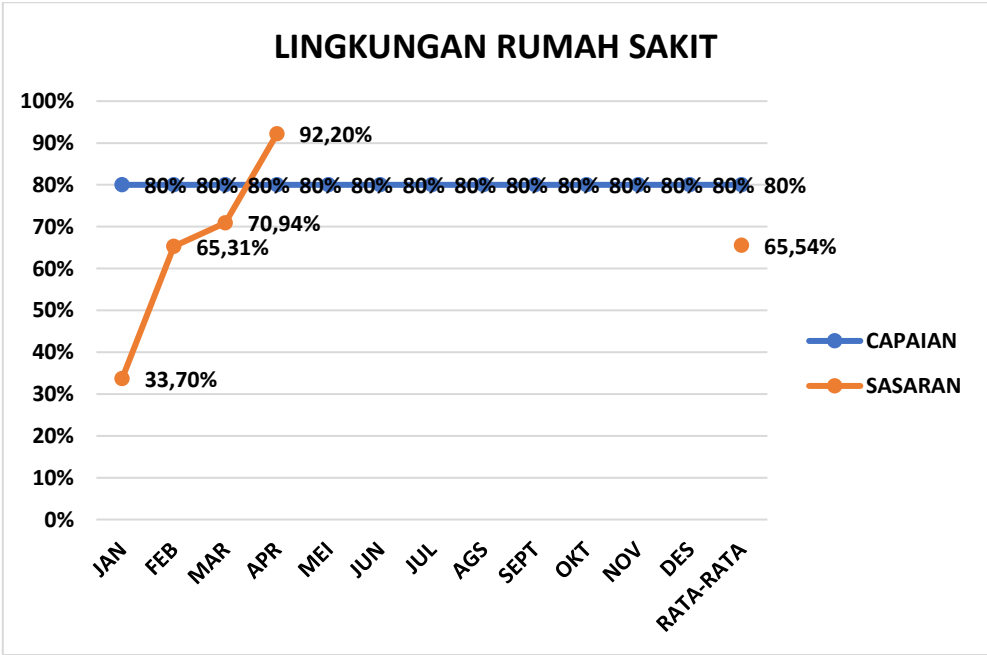


[illegible]

BAB IV.

PEMBAHASAN KINERJA PRODUKTIFITAS KOMITE PPI

- 6.1 Kinerja Produktifitas Komite PPI
- 6.1.1 Monitoring Kewaspadaan Isolasi
- a. Kewaspadaan Standart
- a) Lingkungan Rumah Sakit
- Gambar 4.1.1.1 Lingkungan Rumah Sakit



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.1 diketahui bahwa rerata lingkungan rumah sakit di bulan April 2025 sebesar 92,20% dan belum mencapai standart 80%.

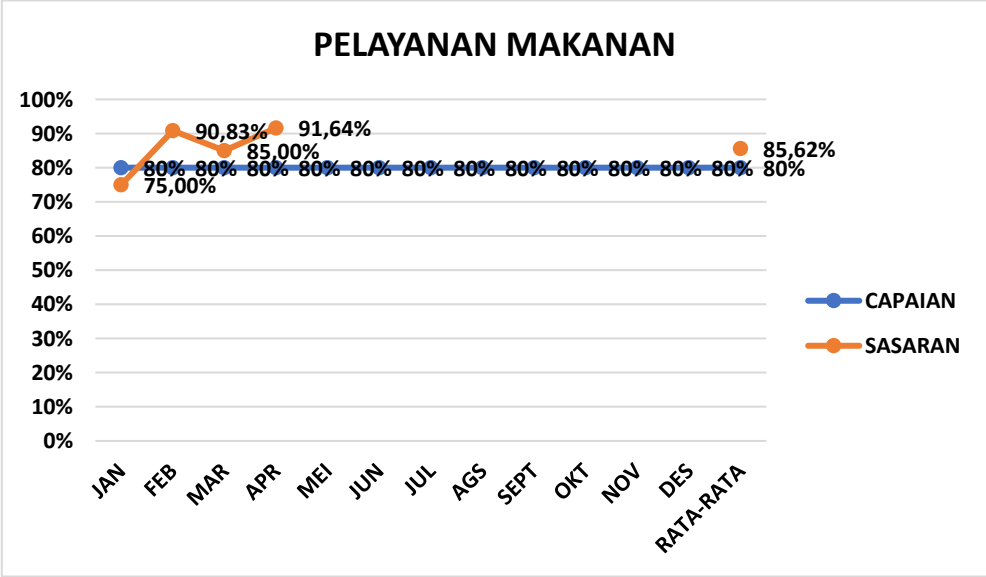
Tabel 4.1.1.1 Lingkungan Rumah Sakit

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBLEM | Data menunjukkan fluktuasi Tingkat kepatuhan dengan rerata 65,54%, jauh di bawah target 80%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| STEP    | Memonitor berkelanjutan dalam mempertahankan atau meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan rumah sakit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PLAN    | <div>1. Rencana:<br/>Meningkatkan kepatuhan terhadap kebersihan lingkungan rumah sakit hingga minimal 80% sesuai target pada semua bulan</div> <div>2. Harapan<br/>Seluruh staf patuh dalam pengendalian infeksi lingkungan di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai.</div> <div>3. Analisa penyebab potensial<div>a. Kurangnya pelatihan staff dalam kebersihan</div><div>b. Pengawasan atau audit tidak konsisten</div><div>c. Tidak tersosialisasi dan tidak diterapkannya SOP terkait kebersihan lingkungan RS</div><div>d. Kurangnya motivasi atau reward bagi petugas kebersihan yang berdin</div></div> <div>4. Tindakan<div>a. Melakukan audit pengendalian infeksi lingkungan di</div></div> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <div> unit secara berkesinambungan (baik secara mingguan dan memberikan umpan balik) </div> <div> b. Meningkatkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang pengendalian infeksi lingkungan di unit. </div> <div> c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit. </div> <div> d. Menyusun ulang dan menyebarkan SOP kebersihan area rumah sakit </div> <div> e. Mengadakan pelatihan untuk petugas kebersihan dan staff terkait </div> <div> f. Menyediakan checklist kebersihan harian </div> |
| DO     | Kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan mencapai 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| STUDY  | <div> 1. Nilai kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan bulan April tahun 2025 yaitu sebesar 90,20% dengan rerata sebesar 65,54% dan belum mencapai sasaran 80%. </div> <div> 2. Monitoring capaian kepatuhan setiap minggu </div> <div> 3. Bandingkan hasil kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan dengan bulan sebelumnya </div> <div> 4. Evaluasi area dengan peningkatan dan penurunan </div> <div> 5. Survei kepuasan staff dan petugas terhadap sistem baru </div>                                                                               |
| ACTION | <div> 1. Kolaborasi dengan tim umum terkait pengadaan sumber daya pembersihan lingkungan dengan baik sesuai dengan standart </div> <div> 2. Beri feedback pada hasil temuan </div> <div> 3. Beri teguran saat melakukan monitoring pengendalian infeksi lingkungan di unit dengan SOP dan audit sebagai standar rutin </div> <div> 4. Monitoring pembersihan dan disinfeksi permukaan lingkungan yang berisiko tinggi sesuai dengan SOP dan audit sebagai standar rutin </div>                                                                             |

b) Pelayanan Makanan

Gambar 4.1.1.2 Pelayanan Makanan



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.2 diketahui bahwa rerata pelayanan makanan di bulan April 2025 sebesar 91,64% dan sudah mencapai standart 80%.

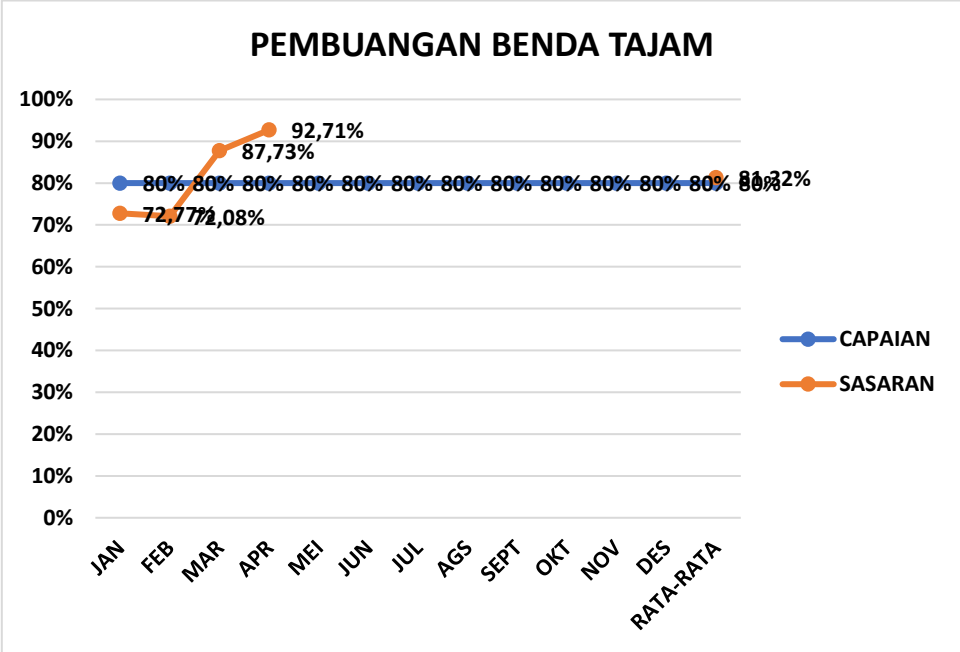
Tabel 4.1.1.2 Pelayanan Makanan

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROBLEM</b> | Data menunjukkan fluktuasi tingkat kepatuhan dengan rerata 85,62% dan sudah mencapai target 80%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>STEP</b>    | Memonitor kelanjutan dalam mempertahankan atau meningkatkan kepatuhan pelayanan makanan di area rumah sakit untuk mencegah dan mengendalikan penularan infeksi yang dapat diperoleh dari asupan gizi yang berada di lingkungan rumah sakit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PLAN</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana:<br/>Meningkatkan mutu pelayanan makanan di rumah sakit agar mencapai target minimal 80% setiap bulannya.</li> <li>Analisa penyebab potensial <ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya control kualitas makanan sebelum distribursi</li> <li>Kurangnya koordinasi antara dapur dan pelayanan pasien</li> <li>Tidakpatuhnya staff dalam melakukan HH dan penggunaan APD</li> </ol> </li> <li>Tindakan <ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi alur kerja distribusi makanan</li> <li>Pelatihan ulang petugas gizi dan dapur terkait standart pelayanan makanan</li> <li>Pengadaan cheklist control kualitas makanan sebelum distribusi</li> <li>Monitoring harian dan evaluasi mingguan terhadap pelayanan makanan</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>DO</b>      | Kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan mencapai 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>STUDY</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Nilai kepatuhan pelayanan makanan bulan April tahun 2025 yaitu sebesar 91,64% dengan rerata sebesar 85,62% dan sudah mencapai target 80%.</li> <li>Analisis hasil monitoring harian dan evaluasi mingguan</li> <li>Lakukan perbandingan hasil bulan berjalan dengan bulan sebelumnya</li> <li>Identifikasi untir atau waktu yang masih mengalami kendala dalam pelayanan makanan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ACTION</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Beri <i>feedback</i> hasil temuan</li> <li>Koordinasi dengan CS <i>pantry</i> terkait kebersihan ruang dapur dan gizi</li> <li>Monitoring kebersihan tangan dan penggunaan APD di dapur melalui supervise dan lembar audit</li> <li>Terapkan system reward untuk unit atau staff dengan pelayanan terbaik</li> <li>Lanjutkan pemantauan dan penyesuaian system pelayanan makanan sebagai bagian dari standar rutin</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



c) Pembuangan Benda Tajam

Gambar 4.1.1.3 Pembuangan Benda Tajam



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.3 diketahui bahwa rerata pembuangan benda tajam di bulan April 2025 sebesar 81,32% dan sudah mencapai standart 80%.

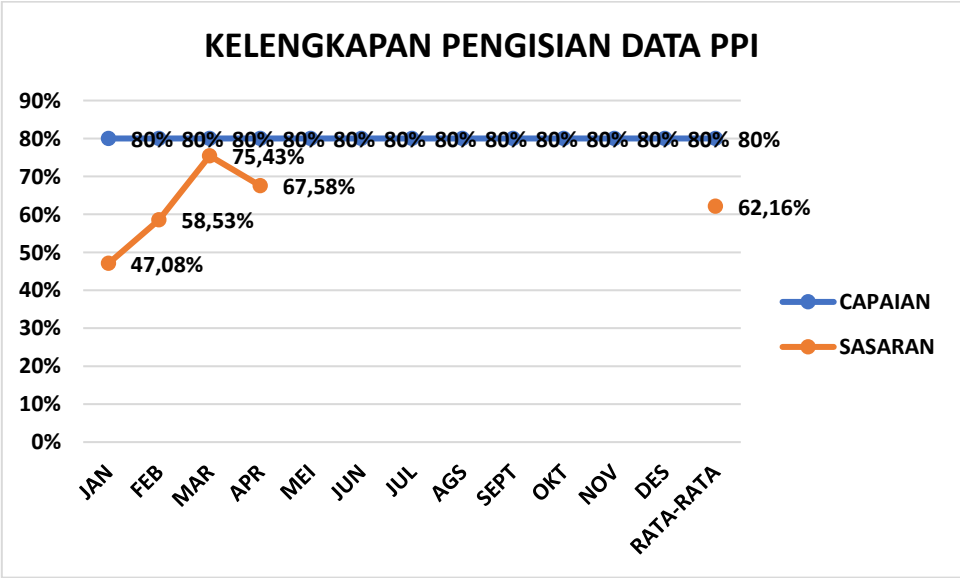
Tabel 4.1.1.3 Pembuangan Benda Tajam

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBLEM | Persentase kepatuhan pembuangan limbah benda tajam belum mencapai 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| STEP    | Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pembuangan jarum dan benda tajam untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertusuk jarum pada petugas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PLAN    | <div>1. Rencana:<br/>Meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur pembuangan benda tajam agar mencapai target minimal 80% setiap bulan.</div> <div>2. Harapan<br/>Seluruh staf patuh dalam pembuangan sampah jarum dan benda tajam di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai.</div> <div>3. Analisa penyebab potensial<div>a. Kurangnya pemahaman staff tentang prosedur pembuangan benda tajam yang benar</div><div>b. Tidak tersedianya tempat pembuangan benda tajam di area kerja (troli injeksi, troli tindakan)</div><div>c. Pengawasan yang bekum optimal terhadap praktik pembuangan limbah medis tajam</div></div> <div>4. Tindakan<div>a. Melakukan audit pembuangan jarum dan benda tajam di unit secara</div></div> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | berkesinambungan.<br>b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang pembuangan jarum dan benda tajam di unit.<br>c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam di unit.<br>d. Menyediakan safety box diseluruh titik layanan<br>e. Lakukan pelatihan ulang kepada seluruh staff pelayanan terkait pembuangan benda tajam yang aman<br>f. Lakukan review ulang SOP pembuangan benda tajam atau lakukan pembuatan dan penempatan poster diarea strategis |
| DO     | Kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam meningkat hingga mencapai 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| STUDY  | 1. Rerata kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam bulan April tahun 2025 yaitu sebesar 92,71 dengan rerata 81,32% dan sudah mencapai target 100%,<br>2. Evaluasi mingguan dari pelaporan IPCLN unit<br>3. Bandingkan data kepatuhan bulan berjalan dengan sebelumnya<br>4. Identifikasi unit dengan kendala dalam penerapan SOP                                                                                                                                                                         |
| ACTION | 1. Review kepada staf terkait pembuangan jarum dan benda tajam.<br>2. Lakukan <i>supervise</i> terhadap jumlah stok <i>safety box</i> di area pelayanan yang ditunjukkan dengan bukti <i>spreedshet</i> jumlah kebutuhan dan jumlah pemakaian di all lantai<br>3. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan.<br>4. Beri teguran saat melakukan monitoring pembuangan jarum dan benda tajam di unit.                                                                                                           |

d) Kelengkapan Penginputan Data Surveilans

Gambar 4.1.1.4 Kelengkapan Penginputan Data Surveilans



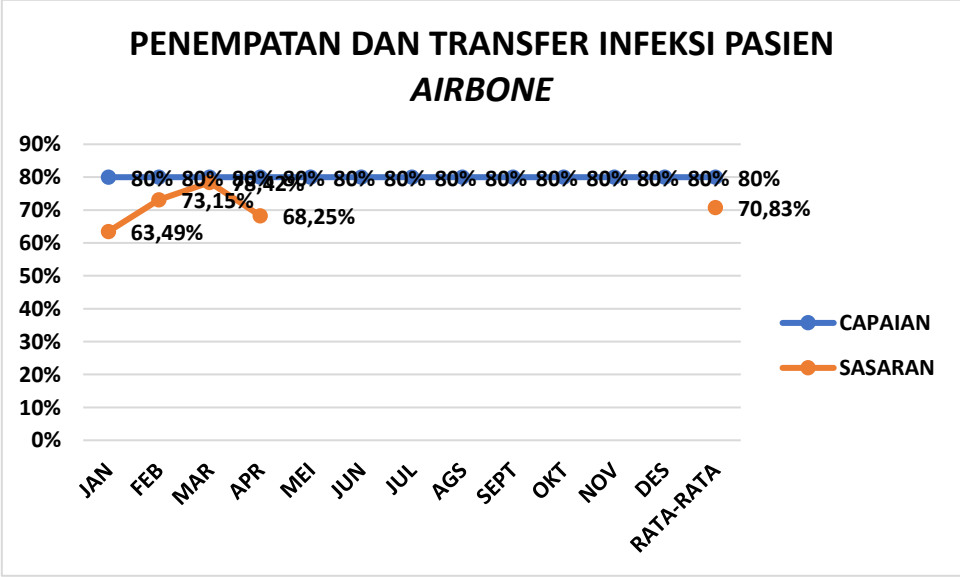
Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.4 diketahui bahwa rerata kelengkapan penginputan data surveilans di bulan April 2025 sebesar 62,16% dan belum mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.4 Kelengkapan Penginputan Data Surveilans

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROBLEM</b> | Persentase kelengkapan penginputan data surveilans bulan Maret tahun 2025 sebesar 75,43% dan belum memenuhi target 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>STEP</b>    | Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pelaporan dan penginputan hasil serta temuan di unit terkait surveilans HAI's dan monitoring 11 kewaspadaan transmisi serta kewaspadaan isolasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PLAN</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana:<br/>Meningkatkan kelengkapan pengisian data pencegahan dan pegendaian infeksi hingga mencapai target minimal 80% setiap bulan</li> <li>Harapan<br/>Seluruh IPCLN dan PIC PPI unit melakukan penginputan data surveilans secara <i>real time</i> dan <i>ontime</i> sehingga target kepatuhan dapat tercapai.</li> <li>Analisa penyebab potensial <ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya pemahaman staff tetang pentingnya pencatatan data PPI</li> <li>Format pencatatan yang banyak yang harus di isi oleh PJ unit</li> <li>Tidak adanya system monitoring pengisian data secara rutin</li> </ol> </li> <li>Tindakan <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi kepada seluruh IPCLN dan PIC PPI terhadap pelaporan melalui web PPI <a href="https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo">https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo</a></li> <li>Berkolaborasi dengan kepala ruang, kepala bidan dan SDM terkait kepatuhan IPCLN dan PIC PPI dalam melakukan kepatuhan penginputan data surveilans dan monitoring 11 kewaspadaan standart serta kewaspadaan isolasi</li> <li>Memberikan pelatihan kepada seluruh staff terkait pengisian data</li> <li>Monitoring mingguan oleh tim PPI terhadap pengisian data</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>DO</b>      | Kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans belum mencapai target 80%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>STUDY</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Rerata kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans di bulan April 2025 sebesar 67,58 % dengan rerata 62,16% dan belum memenuhi standart 80%</li> <li>Analisis unit yang mengalami peningkatan dan penurunan capaian</li> <li>Lakukan survei terhadap staff untuk mengetahui hambatan dalam pengisian</li> <li>Bandingkan tingkat kelengkapan data bulan berjalan dengan bulan sebelumnya</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ACTION</b>  | 1. Lakukan evaluasi pengisian form PPI by web setiap bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div> 2. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kelengkapan data yang telah di isi dengan melibatkan Karu dan Kabid terkait. </div> <div> 3. Lakukan sosialisasi dan edukasi ulang kepada PIC PPI yang belum faham </div> <div> 4. Lakukan audit per unit dengan identifikasi dan berikan award pada unit dengan tingkat kepatuhan tinggi dalam pelaporan </div> <div> 5. Perbaiki format atau system pengisian berdasarkan masukan staff </div> <div> 6. Berikan feedback hasil audit dan monitoring </div> <div> 7. Berikan teguran pada IPCLN dan PIC PPI yang tidak patuh dalam melakukan pelaporan </div> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- b. Kewaspadaan Transmisi
- a) Penempatan dan Transfer Infeksi Pasien *Airbone*
- Gambar 4.1.1.5 Penempatan dan Transfer Infeksi Pasien *Airbone*



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.5 diketahui bahwa rerata penempatan dan transfer infeksi pasien *airbone* di bulan April 2025 sebesar 70,83% dan belum mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.5 Penempatan dan Transfer Infeksi Pasien *Airbone*

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBLEM | Persentase kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> belum mencapai 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| STEP    | Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan dalam penempatan dan transfer infkesi pasien <i>airbone</i> untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i> |
| PLAN    | 1. Rencana:<br>Meningkatkan kepatuhan terhadap penempatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

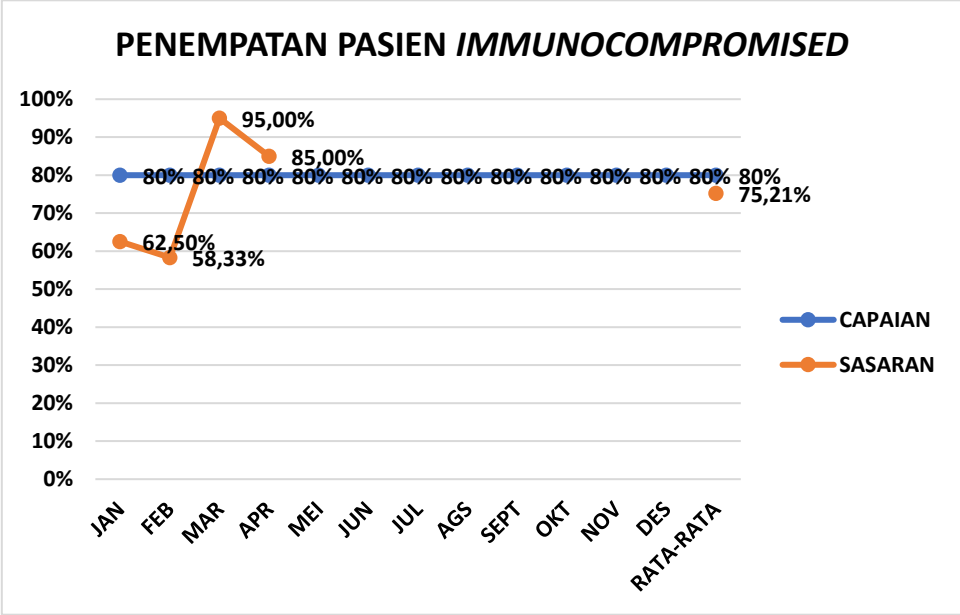


|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>dan transfer pasien dengan infeksi airborne agar mencapai target minimal 80%</p> <p>2. Harapan<br/>Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai.</p> <p>3. Analisa penyebab potensial ;</p> <p>a. Kurangnya pemahaman staff mengenai prosedur airborne precaution</p> <p>b. Tidak semua ruang perawatan dilengkapi system isolasi airborne</p> <p>c. Koordinasi antar unit dalam proses transfer masih lemah</p> <p>4. Tindakan</p> <p>a. Melakukan audit kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> di unit secara berkesinambungan.</p> <p>b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> sesuai dengan SOP dan standart yang berlaku</p> <p>c. Koordinasi dengan IPCLN melalui grub komunikasi aktif di unit untuk meningkatkan kepatuhan kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.</p> |
| <b>DO</b>     | Kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> belum mencapai 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>STUDY</b>  | <p>1. Rerata kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> bulan April tahun 2025 yaitu sebesar 68,25 dengan rerata capaian 70,83% dan belum mencapai target 80%,</p> <p>2. Monitoring kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> dilakukan secara mingguan</p> <p>3. Evaluasi dilakukan terhadap proses transfer yang terjadi setiap bulan</p> <p>4. Lakukan audit terhadap dokumentasi penempatan pasien</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ACTION</b> | <p>1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i>.</p> <p>2. Lakukan koordinasi dengan Karu IRNA 2A untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi</p> <p>3. Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video)</p> <p>4. Aktivkan CCTV diarea R. Isolasi dan lakukan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | kolaborasi dengan satpam RS untuk penertiban pengunjung di area ruang Isolasi,<br>5. Perkuat system pemantauan dan laporan internal<br>6. Beri pelatihan sebagai agenda rutin tiap semester<br>7. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan,<br>8. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> dengan tepat |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

b) Penempatan Pasien *Immunocomprissed*

Gambar 4.1.1.6 Penempatan Pasien *Immunocomprissed*



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.6 diketahui bahwa rerata kepatuhan penempatan pasien *immunocomprissed* di bulan April 2025 sebesar 75,21% dan belum mencapai standart 80%.

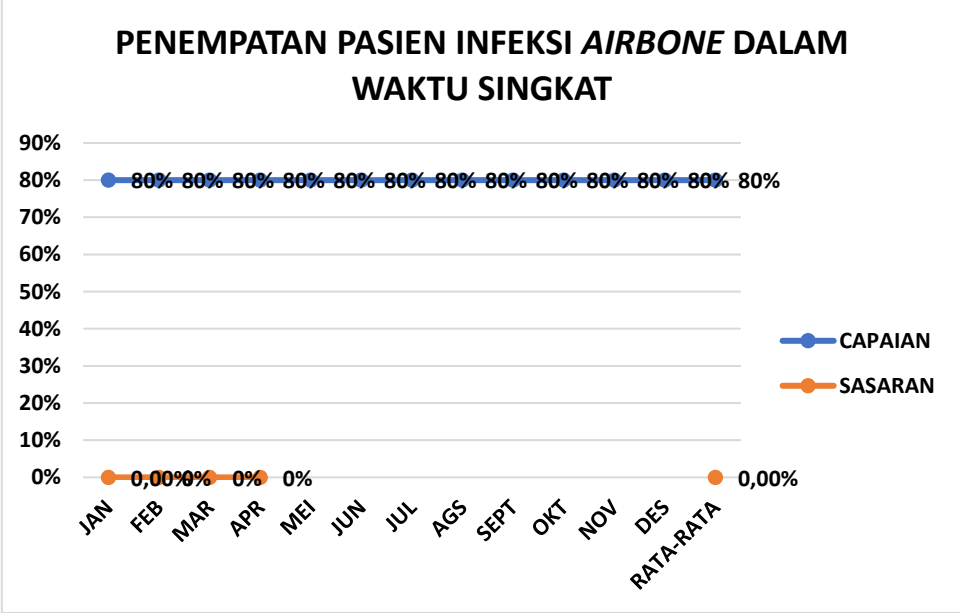
Tabel 4.1.1.5 Penempatan Pasien *Immunocomprissed*

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBLEM | Persentase kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> belum mencapai 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| STEP    | Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i> . |
| PLAN    | 1. Rencana:<br>Meningkatkan kepatuhan terhadap penempatan pasien immunocompromised sesuai standart dengan target minimal 80%<br>2. Harapan<br>Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai.<br>3. Analisa penyebab potensial;<br>a. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya                                       |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <div> <div>penempatan khusus bagi pasien immunocompromised</div> <div> b. fasilitas ruang isoalsi terbatas c. kelemahan dalam system triase awal dan komunikasi lintas unit </div> </div> <div> 4. Tindakan <div> a. Melakukan audit kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> terhadap proses triase d. Optimalisasi ruang perawatan dengan system kohorting pasien sejenis </div> </div>                                                                                                                               |
| DO     | Kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> belum mencapai 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| STUDY  | <div> 1. Rerata kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> bulan April tahun 2025 yaitu sebesar 85% dengan rerata 75,21% dan belum mencapai standart 80%. 2. Lakukan audit internal mingguan terhadap dokumentasi dan praktik penempatan 3. Data dievaluasi untuk melihat perbaikan dan hambatan dalam proses 4. Lakukan pembahasan secara rutin dalam rapat koordinasi </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ACTION | <div> 1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i>. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu IRNA 2A untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi 3. Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video) 4. Evaluasi keberlanjutan program setiap 3 bulan dan perbaikan berkelanjutan 5. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 6. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> </div> |



- c) Penempatan Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat
- Gambar 4.1.1.7 Penempatan Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.7 diketahui bahwa rerata kepatuhan penempatan pasien infeksi *airbone* dalam waktu singkat di bulan April 2025 sebesar 0% dan belum mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.7 Penempatan Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBLEM | Persentase kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat belum mencapai 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| STEP    | Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit IGD dan rawat inap mengenai pentingnya kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PLAN    | 1. Rencana:<br>Mengetahui kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit secara berkesinambungan.<br>2. Harapan<br>Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai.<br>3. Tindakan <div>             a. Melakukan audit kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit secara berkesinambungan,<br/>             b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat,<br/>             c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat           </div> |

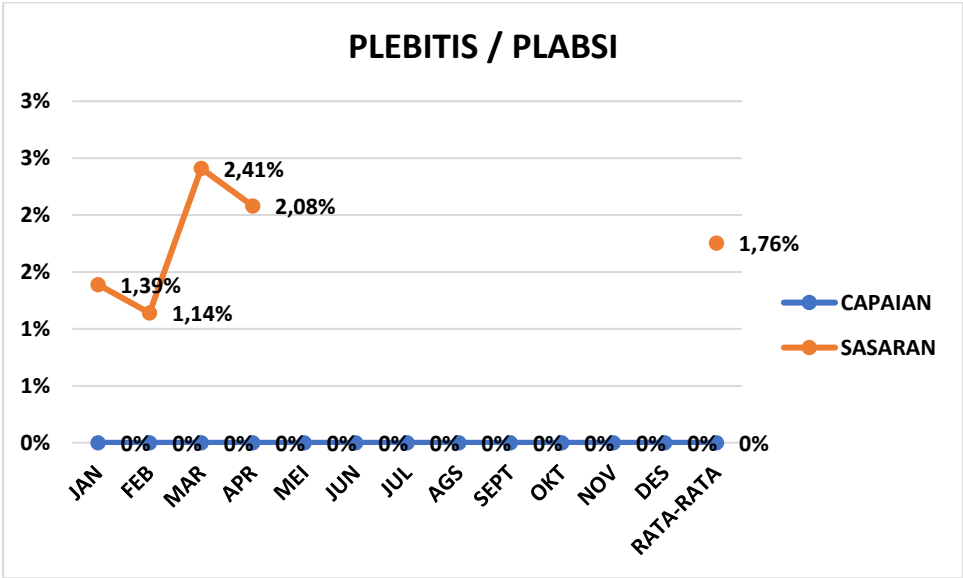


|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DO</b>     | Kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat belum mencapai 80%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STUDY</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rerata kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat bulan Maret tahun 2025 yaitu sebesar 0%,</li> <li>2. Ditemukan data sebesar 0% dikarenakan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat tidak adapat terukur secara <i>real time</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ACTION</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat.</li> <li>2. Lakukan koordinasi dengan Karu IGD untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi</li> <li>3. Lakukan audit secara berkesinambungan Bersama IPCLN IGD</li> <li>4. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan.</li> <li>5. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat.</li> </ol> |

6.1.2 Audit *Bundle* HAI's PPI

a. *Bundle Phlebitis*

Gambar 4.1.2.1 Phlebitis



Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.1 diketahui bahwa rerata kejadian phlebitis di bulan April 2025 sebesar 1,76% dan belum mencapai standart 0%.

Tabel 4.1.2.1 Phlebitis

| No    | Bulan    | Unit        | Jumlah Phlebitis |
|-------|----------|-------------|------------------|
| 1     | Januari  | IRNA 3A     | 11               |
|       |          | IRNA 3B     | 3                |
|       |          | IRNA 2A     | 4                |
|       |          | IRNA 2B     | 2                |
|       |          | MATERNITAS  | 0                |
|       |          | NEONATOLOGI | 0                |
|       |          | ICU         | 0                |
| 2     | Februari | IRNA 3A     | 0                |
|       |          | IRNA 3B     | 3                |
|       |          | IRNA 2A     | 7                |
|       |          | IRNA 2B     | 6                |
|       |          | MATERNITAS  | 0                |
|       |          | NEONATOLOGI | 1                |
|       |          | ICU         | 0                |
| 3     | Maret    | IRNA 3A     | 6                |
|       |          | IRNA 3B     | 7                |
|       |          | IRNA 2A     | 6                |
|       |          | IRNA 2B     | 4                |
|       |          | MATERNITAS  | 2                |
|       |          | NEONATOLOGI | 2                |
|       |          | ICU         | 0                |
|       |          | IRJA        | 7                |
|       |          |             |                  |
| 4     | April    | IRNA 3A     | 15               |
|       |          | IRNA 3B     | 3                |
|       |          | IRNA 2A     | 3                |
|       |          | IRNA 2B     | 7                |
|       |          | NEONATOLOGI | 1                |
|       |          | IRJA        | 2                |
|       |          |             |                  |
| TOTAL |          |             | 102              |

Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.1 diketahui kejadian plebitis terbanyak di unit IRNA 3A sebesar 15 kejadian.

Tabel 4.1.2.2 PDSA Phlebitis

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROBLEM</b> | Persentase kejadian plebitis belum mencapai standart 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>STEP</b>    | Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit IGD dan rawat inap mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan kejadian plebitis untuk mengurangi resiko akibat pemasangan infus dan meningkatkan keselamatan pasien sesuai standart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PLAN</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana:<br/>Menurunkan angka kejadian phlebitis menjadi <math>\leq 1\%</math> dalam 3 bulan .</li> <li>2. Harapan<br/>Seluruh staf patuh dalam pelaporan kejadian plebitis dan dapat menurunkan kejadian plebitis di masing-masing unit.</li> <li>3. Akar masalah yang diidentifikasi; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketidaksesuaian prosedur pemasangan infus</li> <li>b. Lama pemasangan infus &gt;72 jam</li> <li>c. Kurangnya pencatatan dan monitoring harian</li> <li>d. Minimnya pelatihan atau refreshment untuk tenaga medis</li> </ol> </li> <li>4. Tindakan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi SOP pemasangan dan perawatan infus</li> <li>b. Audit harian terhadap pemasangan dan perawatan infus</li> <li>c. Pembatasan lama pemasangan infus maksimal 72 jam</li> <li>d. Pelatihan ulang tenaga medis tentang pencegahan phlebitis</li> <li>e. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>DO</b>      | Angka kejadian plebitis dapat mencapai 0%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>STUDY</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data kejadian phlebitis pada bulan April sebesar 2,08% dengan rerata 1,72% dan belum mencapai target 0%</li> <li>2. Evaluasi angka kejadian phlebitis setiap minggu</li> <li>3. Bandingkan data sebelum dan sesudah intervensi</li> <li>4. Tinjau hasil audit dan identifikasi unit yang masih belum patuh terhadap SOP</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ACTION</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika angka menurun : terapkan intervensi sebagai prosedur standart baru</li> <li>2. Jika angka tetap tinggi; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi Kembali penyebab utama</li> <li>b. Tambahkan intervensi, seperti supervise lebih ketat dan intensif terhadap kepatuhan</li> <li>c. Pertimbangkan revisi SOP bila tidak sesuai praktik lapangan</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

---

Link                  rekap                  Plebitis                  PPI                  2025                  :

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XjGil\\_YwmlziDYeUHxce3xvO36M89OgWvYhlgKjDDWE/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XjGil_YwmlziDYeUHxce3xvO36M89OgWvYhlgKjDDWE/edit?usp=sharing)

b. Bundle IDO

Gambar 4.1.2.1 Bundle IDO

| RUMAH SAKIT<br>PRIMA HUSADA |                            | LAPORAN DATA ANALISIS INFEKSI DAERAH OPERASI<br>TAHUN 2025 |        |               |       |                            |               |            |                                |                                                                                  |              |              |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                      | PT. DISA PRIMA MEDIKA                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                          |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|----------------------------|---------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| No                          | Bulan/Tanggal<br>Pelaporan | Inisial Pasien                                             | No RM  | Unit          | Usia  | Tgl/Uam MRS                | DPJP          | Penjamin   | Tgl Operasi                    | Da Operasi & Tindakan<br>Operasi                                                 | Tim Operasi  |              |                 |              |                 | Kontrol ke                                                                                                                                                                             | Riwayat Rawat<br>Luka Post Op                                                   | Hasil Penunjang Abnormal                                                                                            |                                                                                      | Terapi Saat ILO                                                                    | Assesmen lain                                                                                                 | Praduga<br>Penyebab ILO                                                                                                                             | RTL                                                                                                                                                                                                | Total<br>Kejadian<br>IDO |
|                             |                            |                                                            |        |               |       |                            |               |            |                                |                                                                                  | Ast Op       | dr.An        | Ast. An         | Instrumen    | Onkolog         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | Saat Op                                                                                                             | Saat IDO                                                                             |                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Januari                     |                            |                                                            |        |               |       |                            |               |            |                                |                                                                                  |              |              |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Februari                    |                            |                                                            |        |               |       |                            |               |            |                                |                                                                                  |              |              |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 1                           | 21/12/2025                 | NY. ZHILA<br>QITRIYAH                                      | 113569 | POLI<br>OBGYN | 27 TH | 2/4/2025                   | DR. SANTOSO   | BPJS KLS 1 | 2/4/2025                       | 01P0AB0 UK 40-41 MDD<br>DG SEVERE OLIGO DG<br>LETAK OBLIQ + LILTAN<br>TALU PUSAT | EDO          | HARLI        | RIZKI           | KIKIS        | SILFI           | -                                                                                                                                                                                      | Ada rembesan di<br>area balutan,<br>terdapat pusah dan<br>berbau tidak<br>sedap | Hb : 12.2<br>L : 8.400<br>T : 198.000                                                                               | -                                                                                    | VIT C 2X1<br>ONCIVA 1X1                                                            | -                                                                                                             | Obesitas 55kg<br>ke 93 kg                                                                                                                           | MENJAGA SALURAN LUKA DASAR<br>TETAP KERING<br><br>BILA TERJADI REMBESAN MAHA<br>DIDANTI<br><br>MAKAN YANG BANYAK TIDAK<br>BOLEH TARAK<br><br>MENURUNKAN BB ATAU<br>MENJAGA BB                      | 1                        |
| 2                           | 2/2/2025                   | NY. KHOIRO<br>UMAH                                         | 081524 | 28            | 54 TH | 11/2/2025<br>11/26/02/2025 | DR. ROSY ZAKI | BPJS KLS 3 | 11/26/02/2025<br>11/28/02/2025 | 1 APPENDICITIS AKUT<br>II ILEUS OBSTRUKTIF                                       | KIKIS<br>EDO | BOBI<br>HERU | ROHMAN<br>AGUNG | ERD<br>ANTOK | DANANG<br>SILFI | Kontrol poli<br>ke 1 post<br>MRS<br>pertama<br>tanggal<br>21/02/2025<br><br>MRS ulang<br>tanggal<br>28/02/2025<br><br>Kontrol poli<br>ke 1 post<br>MRS ke dua<br>tanggal<br>06/03/2025 | Rawat luka<br>terbuka                                                           | OP KE 1<br>Hb 12,4<br>L 8.800<br>T 243.000<br>GOS 340<br><br>OP KE 2<br>Hb 11,5<br>L 23.100<br>T 482.000<br>GOS 428 | -                                                                                    | Ranitidin 2x1<br>Ondans 3x1<br>Santagask 3x1<br>Metronidazole 3x1<br>Meropenem 3x1 | Obat KRS<br>Ceftri 2x200 mg<br>Etorol 2x1<br>OMZ 2x1<br>Batafil 1x1                                           | GDA tinggi                                                                                                                                          | RL luka khusus oleh tenaga ahli<br>Dai DM<br>Penggunaan obat-obatan harus di<br>minum secara teratur<br><br>Rawat luka sap 2 hari sekali di RS<br>PWS                                              | 2                        |
| Maret                       |                            |                                                            |        |               |       |                            |               |            |                                |                                                                                  |              |              |                 |              |                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 1                           | 3/3/2025                   | RUL WIDAYATI                                               | 113570 | POLI<br>BEDAH | 34 TH | 2/27/2025                  | DR. ROSY ZAKI | BPJS KLS 1 | 2/27/2025                      | 2 APPENDICITIS AKUT                                                              | EDO          | BOBI         | AGUNG           | KIKIS        | DANANG          | Kontrol I<br>05/03/2025                                                                                                                                                                | -                                                                               | Hb 14,1<br>L 11.700<br>T 343.000<br>GOS 118                                                                         | -                                                                                    | Obat post kontrol<br>poli<br>Ceftri 2x100<br>Ibu profen 2x100<br>OMZ 2x1           | Rawat luka bersih<br>menggunakan outsel<br>Setiap luka rembes<br>wajib di ganti                               | Mobilisasi<br>sedikit<br>Gizi yang<br>dikonsumsi<br>kurang (protein)<br>Konsumsi air<br>puah kurang                                                 | Rawat luka bersih di rumah dengan<br>cairan NS<br>Banyak mengonsumsi protein<br>hewani<br>Banyak melakukan mobilisasi (tidak<br>melakukan aktivitas berat)<br>Lakukan kompres hangat bila<br>demam | 3                        |
| 2                           | 3/3/2025                   | FARIDA<br>NURDIANA                                         | 035075 | POLI<br>BEDAH | 46 TH | 2/24/2025                  | DR. RIPTA     | BPJS KLS 3 | 2/25/2025                      | 2 APPENDICITIS AKUT +<br>S. CHOLELITIASIS                                        | WAFI         | HARLI        | RIZKI           | FENDRA       | NIMO            | Kontrol I<br>05/03/2025                                                                                                                                                                | -                                                                               | -                                                                                                                   | Obat post kontrol<br>Thiamphenicol 4x1<br>Metronidazole 3x1<br>Atam Mefenamat<br>3x1 | Rawat luka bersih<br>Setiap luka rembes<br>wajib di ganti                          | Mobilisasi<br>sedikit<br>Gizi yang<br>dikonsumsi<br>kurang (protein)<br>/ banyak makan                        | Rawat luka bersih di rumah dengan<br>cairan NS<br>Banyak mengonsumsi protein<br>hewani<br>melakukan mobilisasi (tidak<br>melakukan aktivitas berat) | 4                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 3                           | 2/7/2025                   | RATNA DEWI                                                 | 090619 | POLI<br>BEDAH | 42 TH | 2/23/2025                  | DR. ROSY ZAKI | BPJS KLS 1 | 2/24/2025                      | MAMAE ABRERAN D /<br>EXCISI                                                      | WAFI         | HERU         | ROHMAN          | FENDRA       | DANANG          | Kontrol I<br>28/02/2025<br><br>Kontrol II<br>07/03/2025                                                                                                                                | Keluar darah pada<br>saat kontrol ke<br>dua                                     | Hb 12,9<br>L 5.800<br>T 185.000<br><br>Hasil PA : Jarak                                                             | keluar gumpalan<br>darah di ketiak "area<br>insisi"                                  | Ibu profen 2x1<br>Ceftri 2x100 mg                                                  | Luka tidak di jahit, di<br>tampun menggunakan<br>kasa<br>Luka diberikan<br>outsel, dan ditutup<br>kasa steril | Kurangnya<br>mobilisasi                                                                                                                             | Rawat luka sap 2 hari sekali,<br>Luka yang di aff jahitan diberi dan di<br>tampun kassa<br>Evaluasi kembali 14/03/2025                                                                             | 5                        |

| Logo & Nama RS |                         |                  | LAPORAN DATA ANALISIS INFEKSI DAERAH OPERASI<br>TAHUN 2025 |            |       |             |                              |            |             |                                         |             |       |         |           |            |                                                         |                                                            | Logo & Nama RS                                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |          |
|----------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------|---------|-----------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| No             | Bulan/Tanggal Pelaporan | Initial Pasien   | No RM                                                      | Unit       | Usia  | Tgl/Jam MRS | DPJP                         | Penjamin   | Tgl Operasi | Dx Operasi & Tindakan Operasi           | Tim Operasi |       |         |           | Kontrol ke | Riwayat Rawat Luka Post Op                              | Hasil Penunjang Abnormal                                   |                                                                                                                      | Terapi Saat ILO                             | Asesmen lain                                                                                                                                                                           | Praduga Penyebab ILO                                                                               | RTL                                                                                      | Total Kejadian IDO                                                                                                                                                                     |          |
|                |                         |                  |                                                            |            |       |             |                              |            |             |                                         | Asst Id     | dr An | Asst An | Instrumen |            |                                                         | Onloop                                                     | Saat Op                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        | Saat IDO |
| JANUARI        |                         |                  |                                                            |            |       |             |                              |            |             |                                         |             |       |         |           |            |                                                         |                                                            |                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |          |
| 1              | 3/5/2025                | RAJUL WIDAYATI   | 113570                                                     | POLI BEDAH | 34 TH | 3/27/2025   | DR. ROSY ZAKI                | BPJS KLS 1 | 3/27/2025   | S. APPENDICITIS AKUT                    | EDO         | SOBI  | AGUNG   | KOKIS     | DAFANG     | Kontrol I<br>05/03/2025                                 | -                                                          | Hb 14.1<br>L 11.700<br>T 343.000<br>GDS 115                                                                          | -                                           | Obat post kontrol poli<br>Cefixim 2x100<br>Ibu protin 2x100<br>OMZ 2x1                                                                                                                 | Rawat luka bersih menggunakan salisel<br>Setiap luka rembes wajib di ganti                         | Mobilisasi sedikit<br>Diet yang dikonsumsi kurang (protein)<br>Konsumsi air putih kurang | Rawat luka bersih di rumah dengan saran NS<br>Banyak mengkonsumsi protein hewani<br>Banyak melakukan mobilisasi (tidak melakukan aktivitas berat)<br>Lakukan kompres hangat bila demam | 3        |
| 2              | 3/5/2025                | FARIDA NUROJAHNA | 035075                                                     | POLI BEDAH | 48 TH | 3/24/2025   | DR. RIFTA                    | BPJS KLS 3 | 3/25/2025   | S. APPENDICITIS AKUT + S. CHOLELITIASIS | WAFI        | HARLI | RIZKI   | FENDRA    | NKO        | Kontrol I<br>05/03/2025                                 | -                                                          | -                                                                                                                    | -                                           | Obat post kontrol<br>Thiamphenicol 4x1<br>Metronidazole 3x1<br>Asam Mefenamat 3x1                                                                                                      | Rawat luka bersih<br>Setiap luka rembes wajib di ganti                                             | Mobilisasi sedikit<br>Diet yang dikonsumsi kurang (protein)<br>Konsumsi air putih kurang | Rawat luka bersih di rumah dengan saran NS<br>Banyak mengkonsumsi protein hewani<br>melakukan mobilisasi (tidak melakukan aktivitas berat)                                             | 4        |
| 3              | 3/7/2025                | RATNA DEWI       | 060619                                                     | POLI BEDAH | 42 TH | 3/23/2025   | DR. ROSY ZAKI                | BPJS KLS 1 | 3/24/2025   | MAMAE ABRRERAN D1 EXCISI                | WAFI        | HERU  | ROHMAN  | FENDRA    | DAFANG     | Kontrol I<br>28/02/2025<br><br>Kontrol II<br>07/02/2025 | Keluar darah pada saat kontrol ke dua                      | Hb 12.8<br>L 9.800<br>T 165.000<br><br>Hasil PA : Jinak                                                              | Keluar gumpalan darah di ketiak "area insa" | Ibu protin 2x1<br>Cefixim 2x100 mg                                                                                                                                                     | Luka tidak di jahit, di tampon menggunakan kasa<br>Luka diberikan salisel, dan ditutup kasa steril | Kurangnya mobilisasi                                                                     | Rawat luka tiap 2 hari sekali.<br>Luka yang di aff jahitan diberi dan di tampon kasa<br>Evaluasi kembali 14/03/2025                                                                    | 5        |
| 4              | 3/24/2025               | LUTFIAMINOSH     | 067905                                                     | IRRA 2A    | 35 TH | 3/23/2025   | DR. SANTOSO<br>DR. ROSY ZAKI | BPJS KLS 1 | 3/12/2025   | MIGRA UTERI                             | EDO         | HARLI | RIZKI   | EKO       | NKO        | Kontrol I<br>20/03/2025                                 | Keluar pual diantara jahitan pasien ketika di basuh ke IDO | Hb 10.1<br>L 9.200<br>T 566.000<br>GDS 70<br>PPT 13.0<br>APPT 30.5<br><br>POST op<br>Hb 9.2<br>L 10.500<br>T 567.000 | Hb 10.3<br>L 15.100<br>T 540.000            | Cefixim 2x1<br>Metronidazol 3x1<br>Santogewak 3x1<br>Ranitidin 2x1<br><br>Obat TB<br>Rifampisin 0-0-450mg<br>Prasitnamid 0-0-500mg<br>Isoniazid 0-0-1<br><br>Racun elambutol 0-0-500mg | Rawat luka menggunakan salisel tiap pagi atau bila rembes                                          | Diet pasien kurang                                                                       | Rawat luka tiap pagi<br>Konsumsi obat TB                                                                                                                                               | 6        |
| April          |                         |                  |                                                            |            |       |             |                              |            |             |                                         |             |       |         |           |            |                                                         |                                                            |                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |          |
|                |                         |                  |                                                            |            |       |             |                              |            |             |                                         |             |       |         |           |            |                                                         |                                                            |                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |          |
| Juni           |                         |                  |                                                            |            |       |             |                              |            |             |                                         |             |       |         |           |            |                                                         |                                                            |                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |          |
|                |                         |                  |                                                            |            |       |             |                              |            |             |                                         |             |       |         |           |            |                                                         |                                                            |                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |          |
| Juli           |                         |                  |                                                            |            |       |             |                              |            |             |                                         |             |       |         |           |            |                                                         |                                                            |                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |          |
|                |                         |                  |                                                            |            |       |             |                              |            |             |                                         |             |       |         |           |            |                                                         |                                                            |                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |          |
| Agustus        |                         |                  |                                                            |            |       |             |                              |            |             |                                         |             |       |         |           |            |                                                         |                                                            |                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |          |
|                |                         |                  |                                                            |            |       |             |                              |            |             |                                         |             |       |         |           |            |                                                         |                                                            |                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |          |
| September      |                         |                  |                                                            |            |       |             |                              |            |             |                                         |             |       |         |           |            |                                                         |                                                            |                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |          |
|                |                         |                  |                                                            |            |       |             |                              |            |             |                                         |             |       |         |           |            |                                                         |                                                            |                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |          |
| Oktober        |                         |                  |                                                            |            |       |             |                              |            |             |                                         |             |       |         |           |            |                                                         |                                                            |                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |          |
|                |                         |                  |                                                            |            |       |             |                              |            |             |                                         |             |       |         |           |            |                                                         |                                                            |                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |          |
| November       |                         |                  |                                                            |            |       |             |                              |            |             |                                         |             |       |         |           |            |                                                         |                                                            |                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |          |

Interpretasi : Berdasarkan gambar 4.1.2.3 dapat diketahui jumlah Bundle IDO di bulan April 0 kasus.

Link Rekap analisa IDO 2025 :

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B0O4PmS-ooVztJNlJw\\_Te2hQkENP-MWt/edit?usp=sharing&ouid=112970937896793169786&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B0O4PmS-ooVztJNlJw_Te2hQkENP-MWt/edit?usp=sharing&ouid=112970937896793169786&rtpof=true&sd=true)

Tabel 4.1.2.3 PDSA Bundle IDO

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROBLEM</b> | Persentase kejadian IDO dengan rerata 1,19% dan belum mencapai standar 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STEP</b>    | Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit IGD dan rawat inap mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan kejadian IDO untuk mengurangi resiko akibat pemasangan infus dan meningkatkan keselamatan pasien sesuai standart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PLAN</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana:<br/>Menurunkan angka kejadian IDO menjadi &lt;0,2% dalam 3 bulan kedepan.</li> <li>2. Harapan<br/>Seluruh staf patuh dalam pelaporan kejadian IDO dan dapat menurunkan kejadian IDO di masing-masing unit.</li> <li>3. Akar masalah yang diidentifikasi; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepatuhan aseptis saat operasi belum maksimal</li> <li>b. Sterilisasi alat belum diaudit secara menyeluruh</li> <li>c. Antibiotic profilaksis tidak diberikan tepat waktu</li> <li>d. Monitoring luka pascaoperasi belum optimal</li> </ol> </li> <li>4. Tindakan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penegakkan protocol aseptis secara ketat (5 momen kebersihan tangan, sterilisasi alat, dan penggunaan APD yang sesuai)</li> <li>b. Pemberian antibiotic profilaksis 30-60 menit sebelum insisi</li> <li>c. Audit sterilisasi alat operasi</li> <li>d. Monitoring luka operasi dan edukasi pasien post-op</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>DO</b>      | <p>Angka kejadian plebitis dapat mencapai 0% dengan menerapkan,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terapkan system cheklist pre-op untuk memastikan pemberian antibiotic dan sterilisasi</li> <li>2. Lakukan pelatihan ulang tim bedah dan perawat mengenai protocol pencegahan IDO</li> <li>3. Audit harian pada ruang operasi dan rawat inap pasca-operasi</li> <li>4. Edukasi psien dan keluarga tentang perawatan luka di rumah</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STUDY</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data kejadian IDO pada bulan April sebesar 0 kejadian dengan rerata kejadian 0,52% dan belum mencapai target 0%</li> <li>2. Tinjau tren angka IDO setiap minggu</li> <li>3. Lakukan evaluasi melalui audit kepatuhan prosedur dan insiden harian</li> <li>4. Identifikasi apakah terjadi penurunan kejadian dan kepatuhan meningkat</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ACTION</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika angka IDO menurun : terapkan prosedur sebagai standar dan teruskan monitoring</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



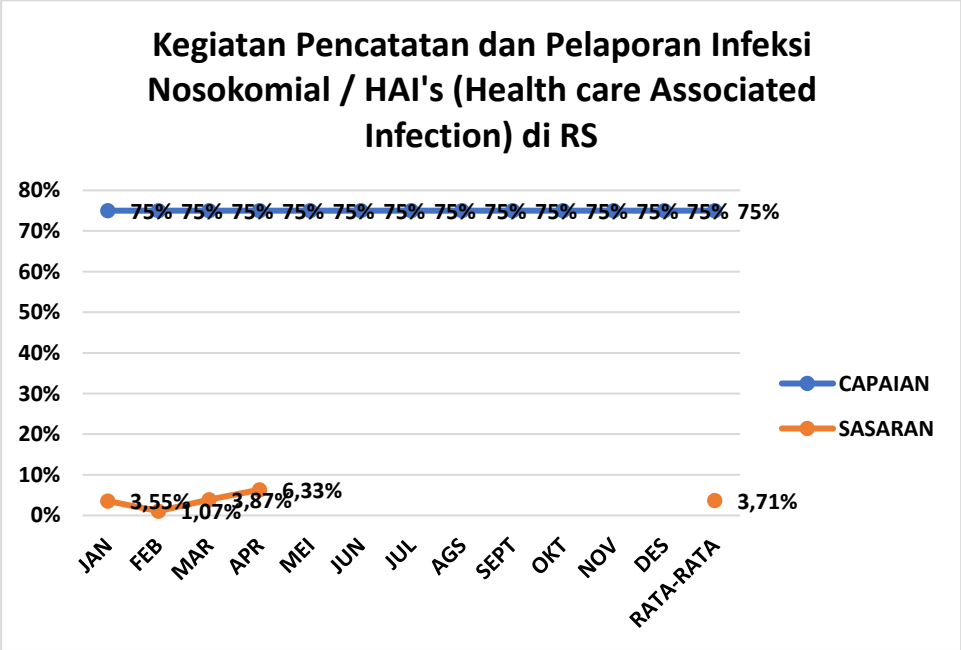
|  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2. Jika belum berhasil maka,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Perbaiki SOP sesuai temuan lapangan</li><li>b. Tambah frekuensi supervise dan audit</li><li>c. Evaluasi kinerja individu yang tidak patuh dan lakukan pembinaan</li></ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



6.1.3 Mutu PPI

a. Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan HAI's

Gambar 4.1.3.1 Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan HAI's



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.1 diketahui bahwa rerata kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's di bulan April 2025 sebesar 3,71% dan belum mencapai standart 75%.

Tabel 4.1.3.1 Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan HAI's

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBLEM | Persentasi kepatuhan kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's belum mencapai 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| STEP    | Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PLAN    | 1. Rencana:<br>Meningkatkan kualitas dan ketepatan pelaporan HAI's mencapai 90% kelengkapan data dalam 3 bulan<br>2. Harapan<br>Seluruh staf patuh dalam kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai.<br>3. Akar masalah,<br>a. Ketidaktahuan peugas tentang format pelaporan HAI's<br>b. Kurangnya pemantauan dari tim IPCN/IPCLN<br>c. Sistem pencatatan sudah digital namun staf masih tidak patuh<br>d. Beban kerja tinggi, menyebabkan pencatatatn tidak menjadi prioritas<br>4. Tindakan<br>a. Pelatihan ulang tentang HAI's dan pentingnya |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>pelaporan</p> <p>b. Distribusi ulang format pelaporan yang mudah dipahami</p> <p>c. Monitoring mingguan dari IPCN ke setiap unit</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DO</b>     | <p>Kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's belum mencapai 80% dan akan dilakukan,</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lakukan sosialisasi dan pelatihan awal dalam 1 minggu pertama</li><li>2. Terapkan system pelaporan mingguan berbasis google form (by link : <a href="https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo/home">https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo/home</a>)</li><li>3. IPCN melakukan validasi data mingguan selama 3 bulan</li><li>4. Berikan umpan balik kepada unit dengan Tingkat pelaporan rendah</li></ol> |
| <b>STUDY</b>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rerata kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's bulan April tahun 2025 yaitu sebesar 6,33% dengan rerata 3,71% dan belum mencapai target 75%</li><li>2. Bandingkan Tingkat kelengkapan dan ketepatan laporan HAIs antar unit</li><li>3. Liat tren pelaporan : apakah meningkat dari minggu ke minggu?</li><li>4. Identifikasi kesalahan umum dna kesenjangan pemahaman</li></ol>                                                                                                                                               |
| <b>ACTION</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Re-sosialisasi ulang kepada staf terkait langkah pelaporan HAI's.</li><li>2. Lakukan koordinasi dengan Karu all pelayanan untuk menghimbau IPCLN/PIC PPI unit untuk patuh dalam melaporkan kejadian HAI's dengan waktu perekapan selama 1 minggu sekali</li><li>3. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan.</li><li>4. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's</li></ol>                                                                                                 |

b. Kepatuhan Kebersihan Tangan

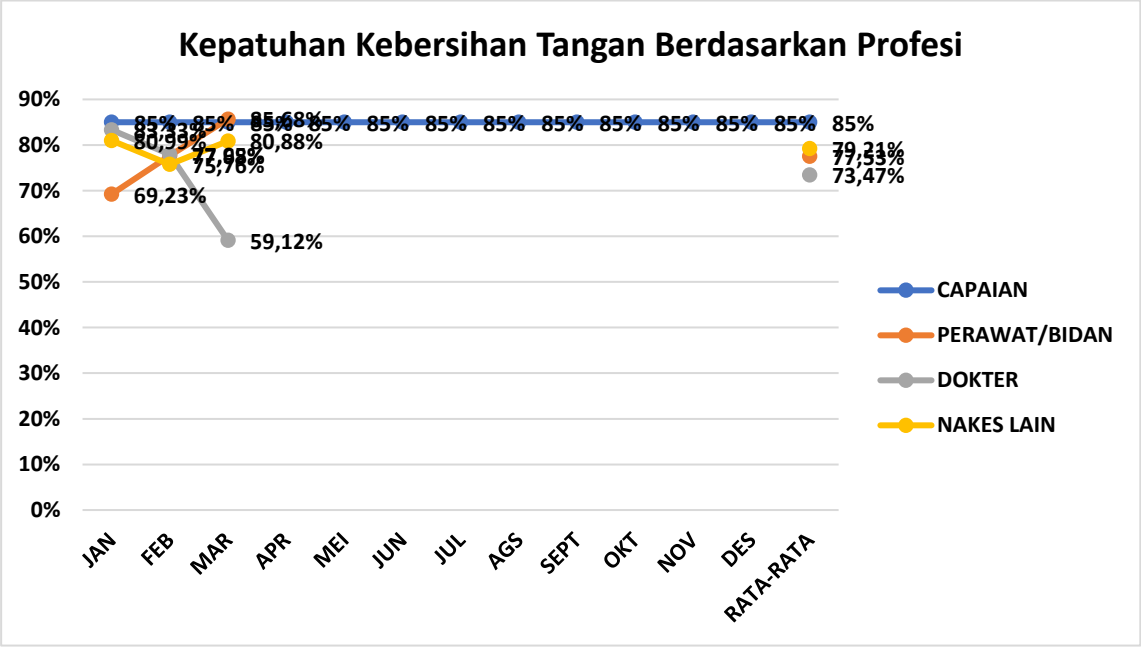
a) Berdasarkan Unit

Tabel 4.1.3.2 Kepatuhan Kebersihan Tangan

| NO | INDIKATOR PENILAIAN | STANDAR T | BULAN  |        |        |        |   |   |   |   |   |    |    |    | RATA-RATA |
|----|---------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------|
|    |                     |           | 1      | 2      | 3      | 4      | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |           |
| 1  | 3A                  | 85%       | 76,36% | 80,77% | 88,41% | 82,46% |   |   |   |   |   |    |    |    | 78,57%    |
| 2  | 3B                  | 85%       | 87,50% | 44,44% | 41,43% | 86,96% |   |   |   |   |   |    |    |    | 65,97%    |
| 3  | 2A                  | 85%       | 100%   | 50,00% | 71,34% | 77,91% |   |   |   |   |   |    |    |    | 75%       |
| 4  | 2B                  | 85%       | 100%   | 100%   | 78%    | 77,91% |   |   |   |   |   |    |    |    | 100%      |
| 5  | 2D                  | 85%       | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     |   |   |   |   |   |    |    |    | 0%        |
| 6  | MAT                 | 85%       | 80%    | 71,79% | 68%    | 86,67% |   |   |   |   |   |    |    |    | 75,90%    |
| 7  | NEO                 | 85%       | 72,73% | 89,02% | 96%    | 88,79% |   |   |   |   |   |    |    |    | 80,88%    |
| 8  | ICU                 | 85%       | 100%   | 100%   | 75%    | 75%    |   |   |   |   |   |    |    |    | 100%      |
| 9  | IKO                 | 85%       | 100%   | 44,44% | 0%     | 75%    |   |   |   |   |   |    |    |    | 72,22%    |
| 10 | IGD                 | 85%       | 58,57% | 77,78% | 84%    | 82,35% |   |   |   |   |   |    |    |    | 68,18%    |
| 11 | IRJA                | 85%       | 100%   | 78,23% | 83%    | 84,40% |   |   |   |   |   |    |    |    | 89,12%    |
| 12 | CS                  | 85%       | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     |   |   |   |   |   |    |    |    | 0%        |
| 13 | As. Center          | 85%       | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     |   |   |   |   |   |    |    |    | 0%        |
| 14 | Farmasi             | 85%       | 100%   | 72,41% | 0%     | 88,10% |   |   |   |   |   |    |    |    | 86,21%    |
| 15 | Laboratorium        | 85%       | 100%   | 100%   | 94%    | 88,51% |   |   |   |   |   |    |    |    | 100%      |
| 16 | Radiologi           | 85%       | 0%     | 100%   | 0%     | 77,78% |   |   |   |   |   |    |    |    | 50%       |
| 17 | Gizi dan Dapur      | 85%       | 62,50% | 78,26% | 97%    | 84,72% |   |   |   |   |   |    |    |    | 70,38%    |
| 18 | RM / PDF            | 85%       | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     |   |   |   |   |   |    |    |    | 0%        |
| 19 | CSSD                | 85%       | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     |   |   |   |   |   |    |    |    | 0%        |
| 20 | LAUNDRY             | 85%       | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     |   |   |   |   |   |    |    |    | 0%        |

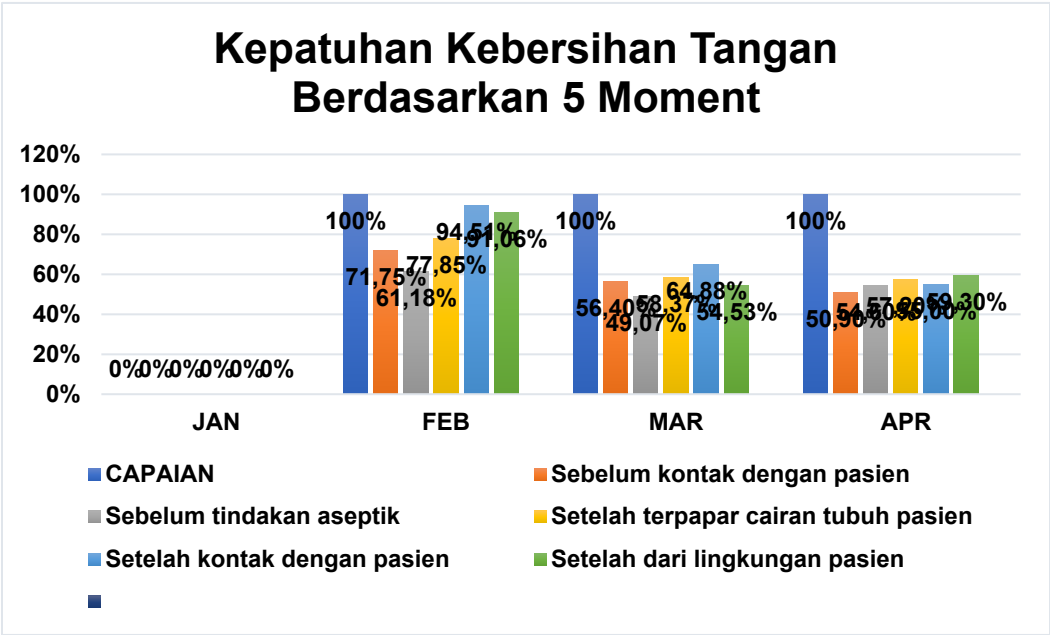
Interpretasi : Pada tabel 4.1.3.2 diketahui kepatuhan kebersihan tangan pada bulan April 2025 tertinggi berada pada unit Neonatologi dengan rerata 96%.

b) Berdasarkan Profesi  
Gambar 4.1.3.2 Kepatuhan Kebersihan Tangan Berdasarkan Profesi



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.2 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan profesi di bulan April 2025 sebesar tertinggi pada profesi Perawat dengan rerata 79,21%.

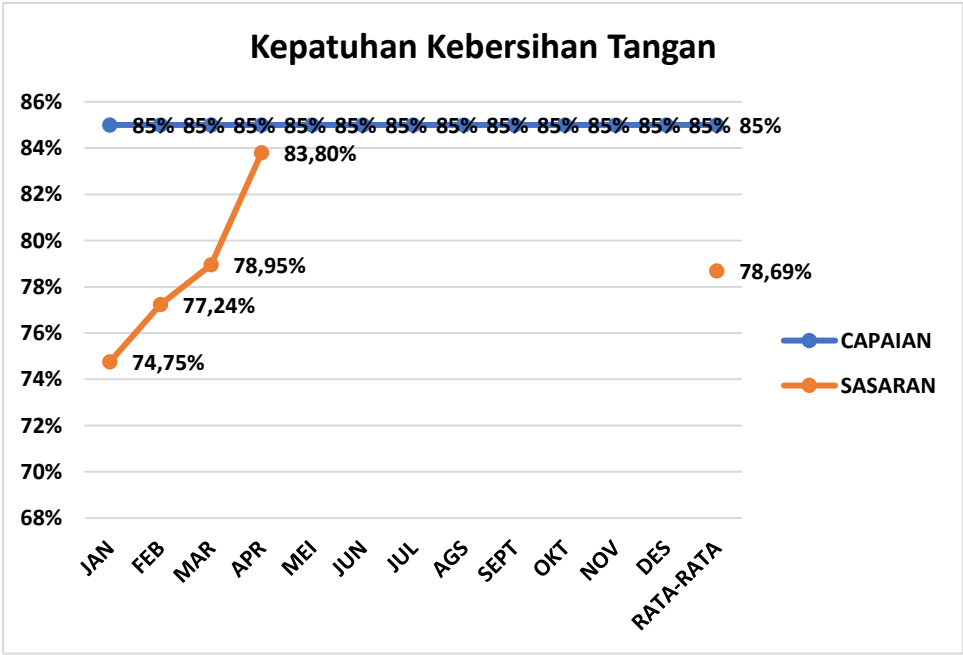
c) Berdasarkan 5 Moment  
Gambar 4.1.3.2.1



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.2 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan 5 moment di bulan April 2025 sebesar

- Sebelum kontak dengan pasien sebesar 50,90%
- Sebelum tindakan aseptik sebesar 54,60%
- Setelah terpapar cairan tubuh pasien sebesar 57,20%
- Setelah kontak dengan pasien sebesar 55%
- Setelah dari lingkungan pasien sebesar 59,40%

Gambar 4.1.3.3 Kepatuhan Kebersihan Tangan



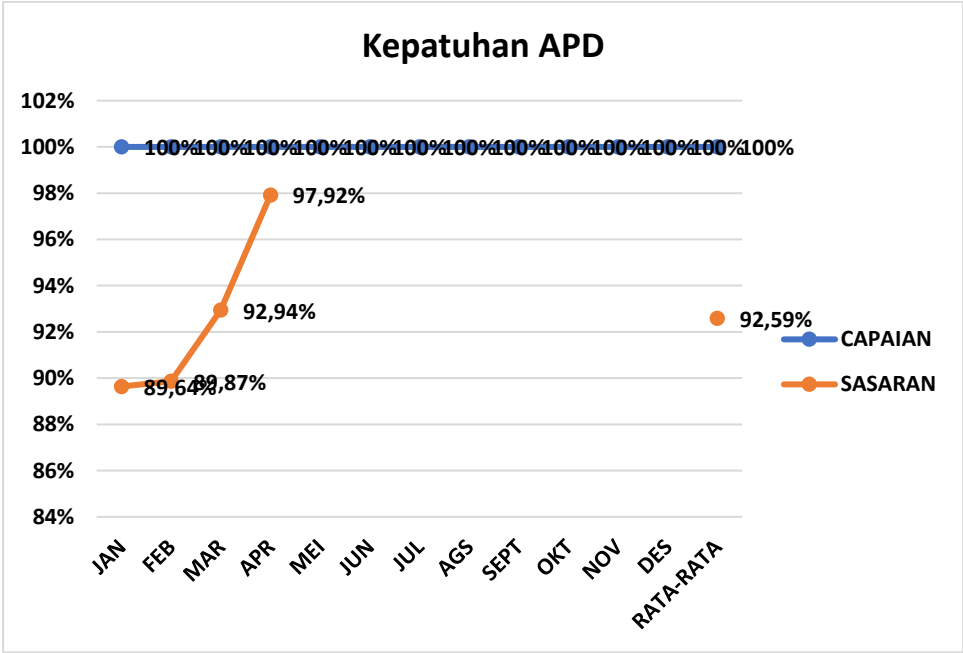
Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.3 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan di bulan April 2025 sebesar 78,69%.

Tabel 4.1.3.3 Kepatuhan Kebersihan Tangan

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBLEM | Persentase kepatuhan kebersihan tangan bulan April tahun 2025 sebesar 83.80% dan belum memenuhi target ≥85%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| STEP    | Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PLAN    | <div> 1. Rencana:<br/>Mencapai kepatuhan minimal 90% dalam 3 bulan dan mempertahankan minimal 85% secara berkelanjutan </div> <div> 2. Harapan<br/>Seluruh staf dapat melakukan <i>hand hygiene</i> dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. </div> <div> 3. Akar masalah <div> a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya momen 5 cuci tangan WHO </div> <div> b. Ketersediaan handrub yang belum merata </div> <div> c. Supervise dan feedback belum dilakukan rutin </div> <div> d. Ketergantungan pada pengingat eksternal tidak menjadi kebiasaan </div> </div> <div> 4. Tindakan <div> a. Membuat TOR untuk review pelatihan PPI dasar </div> <div> b. Audit harian oleh IPCN dengan feedback mingguan </div> <div> c. Manfaatkan poster, QR-code edukasi vidieo, dan pengingat audio di area kritis </div> <div> d. Berkolaborasi dengan kepala bidang terkait monitoring kepatuhan </div> <div> e. Membuat rencana metode <i>role play</i> HH untuk staf lama </div> <div> f. Melakukan edukasi kelompok atau individu dengan sasaran pengunjung rumahsakit yang dibuktikan </div> </div> |

dengan video edukasi.

g. Kepatuhan APD  
Gambar 4.1.3.4 Kepatuhan APD



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.4 diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan APD di bulan April 2025 sebesar 92,59%.

Tabel 4.1.3.4 Kepatuhan APD Berdasarkan Unit

| INDIKATOR<br>PENILAIAN | BULAN   |         |         |        |   |   |   |   |   |    |    |    | RATA-<br>RATA |
|------------------------|---------|---------|---------|--------|---|---|---|---|---|----|----|----|---------------|
|                        | 1       | 2       | 3       | 4      | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |               |
| 3A                     | 88,00%  | 100,00% | 93,10 % | 95,15% |   |   |   |   |   |    |    |    | 94%           |
| 3B                     | 100,00% | 90,00%  | 96,77%  | 100%   |   |   |   |   |   |    |    |    | 97%           |
| 2A                     | 33,33%  | 100,00% | 98,04%  | 100%   |   |   |   |   |   |    |    |    | 83%           |
| 2B                     | 100,00% | 100%    | 98,77%  | 100%   |   |   |   |   |   |    |    |    | 100%          |
| 2D                     | 0,00%   | 0%      | 0%      | 0%     |   |   |   |   |   |    |    |    | 0%            |
| MAT                    | 88,00%  | 100%    | 97,22%  | 100%   |   |   |   |   |   |    |    |    | 96%           |
| NEO                    | 88,89%  | 100%    | 100%    | 100%   |   |   |   |   |   |    |    |    | 97%           |
| ICU                    | 100,00% | 100%    | 79,17%  | 45,45% |   |   |   |   |   |    |    |    | 81%           |
| IKO                    | 100,00% | 100%    | 0%      | 0%     |   |   |   |   |   |    |    |    | 50%           |
| IGD                    | 98,65%  | 100%    | 100%    | 100%   |   |   |   |   |   |    |    |    | 100%          |
| IRJA                   | 100,00% | 89%     | 98,98%  | 100%   |   |   |   |   |   |    |    |    | 97%           |
| CS                     | 27,27%  | 100%    | 0%      | 0%     |   |   |   |   |   |    |    |    | 32%           |
| As. Center             | 0,00%   | 0%      | 0%      | 0%     |   |   |   |   |   |    |    |    | 0%            |
| Farmasi                | 100,00% | 100%    | 0%      | 100%   |   |   |   |   |   |    |    |    | 75%           |
| Laboratorium           | 83,33%  | 56%     | 52,38%  | 84,62% |   |   |   |   |   |    |    |    | 69%           |
| Radiologi              | 60,00%  | 0%      | 66,67%  | 100%   |   |   |   |   |   |    |    |    | 57%           |
| Gizi dan Dapur         | 83,33%  | 76%     | 81,16%  | 100%   |   |   |   |   |   |    |    |    | 85%           |
| RM / PDF               | 0,00%   | 0%      | 0%      | 0%     |   |   |   |   |   |    |    |    | 0%            |
| CSSD                   | 100,00% | 0%      | 0%      | 0%     |   |   |   |   |   |    |    |    | 25%           |
| LAUNDRY                | 100,00% | 0%      | 0%      | 0%     |   |   |   |   |   |    |    |    | 25%           |
| B3                     | 87,72%  | 93,75%  | 83,33%  | 100%   |   |   |   |   |   |    |    |    | 91,20%        |
| LAIN-LAIN              | 0,00%   | 0,00%   | 0%      | 0%     |   |   |   |   |   |    |    |    | 0,00%         |

Interpretasi : Pada tabel 4.1.3.4 diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan APD berdasarkan di Unit di bulan April 2025 tertinggi di unit pelayanan.

Tabel 4.1.3.5 Kepatuhan APD

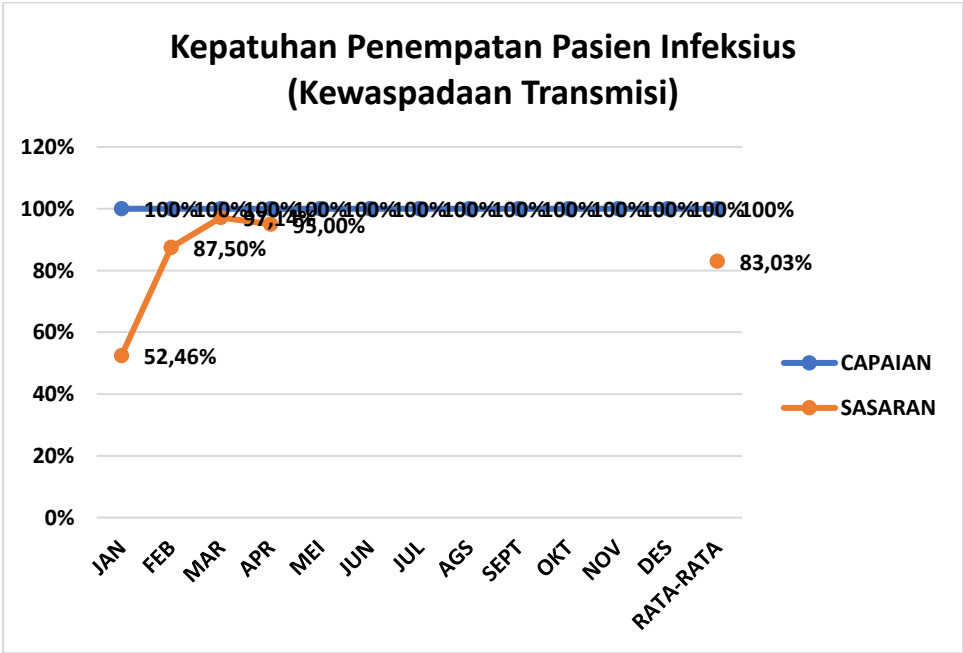
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROBLEM</b> | Persentase kepatuhan penggunaan APD tidak mencapai 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>STEP</b>    | Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PLAN</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana:<br/>Mempertahankan kepatuhan APD di level 100% secara konsisten dalam 6 bulan ke depan</li> <li>2. Harapan<br/>Seluruh staf pelayanan medik patuh dalam penggunaan APD dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai.</li> <li>3. Akar masalah potensial <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketidaknyamanan dalam penggunaan APD (panas, pengap, dll)</li> <li>b. Persepsi bahwa risiko infeksi menurun sehingga kepatuhan bisa longgar</li> <li>c. Ketidakteraturan dalam pengawasan langsung di unit</li> </ol> </li> <li>4. Tindakan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pengingat visual di area kerja (poster, stiker, digital signal)</li> <li>b. Supervise rutin oleh IPCN/IPCLN</li> <li>c. System reward bulanan unit dengan kepatuhan 100%</li> <li>d. Simulasi kasus nyata resiko infeksi akibat ketidakpatuhan</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>DO</b>      | <p>Kepatuhan penggunaan APD meningkat hingga mencapai 100% di bulan April tahun 2025 dengan,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pemasangan materi edukasi dan pengingat di setiap unit</li> <li>2. Lakukan audit dan observasi harian</li> <li>3. Berikan umpan balik mingguan dan apresiasi bagi tenaga yang patuh</li> <li>4. Lakukan survei kecil mengenai kenyamanan dan persepsi staff tentang APD</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>STUDY</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rerata kepatuhan penggunaan APD pada bulan April tahun 2025 yaitu sebesar 97,92% dengan rerata 92,59% dan belum mencapai target 100%</li> <li>2. Pantau tren kepatuhan : apakah tetap stabil di angka 100%</li> <li>3. Analisa hasil audit : apabila ditemukan pelanggaran meskipun tidak dilaporkan</li> <li>4. Evaluasi hasil survei kenyamanan dan motivasi tenaga Kesehatan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ACTION</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf.</li> <li>2. Tinjau factor penyebab (missal APD tidak tersedia, tidak nyaman dalam penggunaan APD)</li> <li>3. Beri feedback pada hasil temuan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div> 4. Kolaborasi dengan Karu masing-masing unit untuk monitoring penggunaan APD di unit. </div> <div> 5. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan Karu unit dan SDM untuk penilaian kinerja. </div> <div> 6. Beri reward pada unit dengan tingakt kepatuhan penggunaan APD 100% </div> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

h. Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius

Gambar 4.1.3.5 Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.5 diketahui bahwa rerata kepatuhan penempatan pasien infeksius di bulan April 2025 sebesar 83,03%.

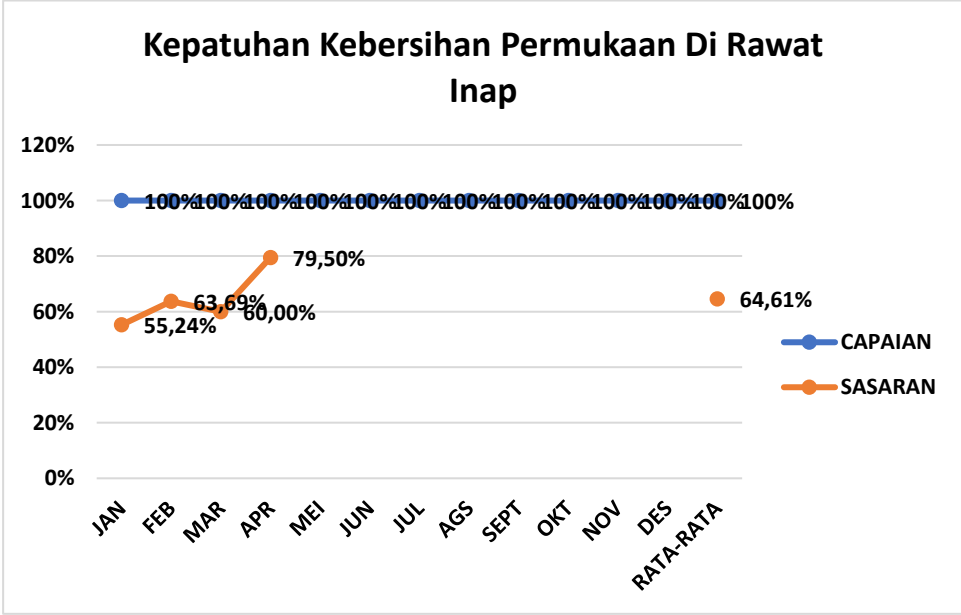
Tabel 4.1.3.6 Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBLEM | Persentase kepatuhan penempatan pasien infeksius belum mencapai 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| STEP    | Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan dalam penempatan pasien infeksius untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i> .                                                   |
| PLAN    | <div> 1. Rencana:<br/> Menajga kepatuhan 100% dalam penempatan pasien infeksius sesuai prinsip kewaspadaan transmisi selama 12 bulan ke depan </div> <div> 2. Harapan<br/> Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien infeksius di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. </div> <div> 3. Akar masalah potensial ; <div> a. Ketidaksesuaian pemahaman tenaga jesehatan tentang klasifikasi pasien infeksius </div> </div> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Sistem triase atau skrining awal tidak optimal</li> <li>c. Ruangan isolasi terbatas atau tidak tersedia disaat dibutuhkan</li> </ul> <p>4. Tindakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Refresh training tentang identifikasi pasien dengan infeksi menular dan protocol penempatannya</li> <li>b. Standarisasi formuli triase dan SOP pemindahan pasien infeksius</li> <li>c. Evaluasi dan optimasi ketersediaan ruang isolasi</li> <li>d. Audit dan umpan balik harian untuk kasus penempatan pasien baru</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DO</b>     | <p>Kepatuhan penempatan pasien infeksius belum mencapai 100% dengan melakukan,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pelatihan ulang kepada perawat IGD, rawat inap dan IPCN</li> <li>2. Terapkan system checklist pada form masuk pasien terkait status infeksi dan tindak lanjut</li> <li>3. Buat system “red flag” di rekam medis pasien dengan infeksi menular</li> <li>4. Monitoring harian oleh IPCN/IPCLN terhadap semua kasus rawat inap baru</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>STUDY</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rerata kepatuhan penempatan pasien infeksius bulan April tahun 2025 yaitu sebesar 95% dengan rerata 83,03% dan belum mencapai target 100%</li> <li>2. Review data audit harian atau mingguan : adakah kasus pasien infeksius tida sesuai dengan tempat?</li> <li>3. Tinjau waktu tunggu antara identifikasi infeksi dan pemindahan pasien</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ACTION</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien infeksius.</li> <li>2. Lakukan koordinasi dengan Karu IRNA 2A untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan pasien infeksius yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi</li> <li>3. Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video)</li> <li>4. Aktivkan CCTV diarea R. Isolasi dan lakukan kolaborasi dengan satpam RS</li> <li>5. Beri feedback pada hasil temuan.</li> <li>6. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan penempatan pasien infeksius.</li> </ul> |

i. Kepatuhan Kebersihan Permukaan di Rawat Inap

Gambar 4.1.3.6 Kepatuhan Kebersihan Permukaan di Rawat Inap



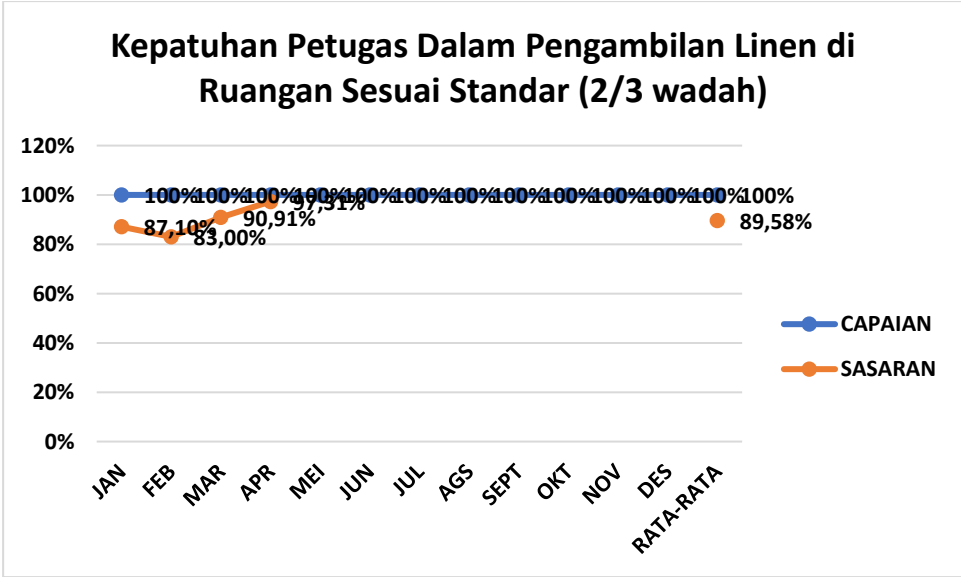
Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.6 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap di bulan April 2025 sebesar 79,50%.

Tabel 4.1.3.7 Kepatuhan Kebersihan Permukaan di Rawat Inap

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBLEM | Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebersihan permukaan di ruang rawat inap yang dapat meningkatkan resiko infeksi nosokomial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| STEP    | Memonitor berkelanjutan dalam mempertahankan atau meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PLAN    | <div> <div>1. Rencana:</div> <div>Meningkatkan kepatuhan kebersihan permukaan menjadi ≥90% selama 3 bulan ke depan</div> </div> <div> <div>2. Harapan</div> <div>Seluruh staf patuh dalam pengendalian infeksi lingkungan di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai.</div> </div> <div> <div>3. Akar masalah</div> <div> <div>a. Petugas CS kurang terlatih atau tidak memahami area kritis</div> <div>b. Ketidakteraturan jadwal atau dokumentasi kebersihan</div> <div>c. Tidak adanya verifikasi atau audit lapangan secara rutin</div> </div> </div> <div> <div>4. Tindakan</div> <div> <div>a. Melakukan audit pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan.</div> <div>b. Meningkatkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang pengendalian infeksi lingkungan di unit.</div> <div>c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit.</div> <div>d. Pelatihan ulang petugas CS tentang standart kebersihan permukaan khususnya area sentuh tinggi</div> <div>e. Pembuatan cheklist harian pembersihan permukaan di setiap ruangan</div> </div> <div> <div>(link</div> <div>jobdisk</div> <div>:</div> <div> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/12xRPis1jwkNrO7">https://drive.google.com/drive/folders/12xRPis1jwkNrO7</a> </div> </div> </div> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <a href="https://drive.google.com/file/d/6kNnKCo73mgiUc51pM/view?usp=drive_link">6kNnKCo73mgiUc51pM?usp=drive_link</a> )<br>5. Sumber daya <ol style="list-style-type: none"> <li>Petugas kebersihan CS yang terlatih</li> <li>Peralatan pembersih yang memadai</li> <li>SOP dan panduan visual untuk kebersihan</li> <li>Peningkatan supervisi lebih sering</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DO</b>     | Monitoring dan audit kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan mencapai target 100% dengan, <ol style="list-style-type: none"> <li>Memastikan setiap kamar kosong dibersihkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan</li> <li>Menggunakan checklist untuk memastikan setiap sudut kamar di bersihkan termasuk tempat tidur, furnitur dan kamar mandi</li> <li>Melakukan sesi pelatihan ulang terkait pembersihan yang lebih detail, terutama pada area tempat tidur, kamar mandi, nakas dan dinding</li> <li>Menggunakan panduan visual yang menunjukkan dengan jelas area yang perlu di bersihkan lebih intensif</li> <li>Melakukan penjadwalan pembersihan tirai/gorden setiap bulan atau lebih sering jika di perlukan</li> <li>Mensosialisasikan pentingnya kebersihan dan penanganan kebersihan lingkungan kepada semua petugas baik kepada CS dan perawat</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STUDY</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Rerata kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap bulan April tahun 2025 yaitu sebesar 79,50 dengan rerata 64,61% dan belum mencapai target 100%</li> <li>Staff belum cukup baik dalam pengendalian kebersihan lingkungan dengan beberapa temuan sebagai berikut,               <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih ditemukan beberapa area perawatan yang berdebu, kotor, dan tidak rapi serta ruangan bau tidak enak</li> <li>CS kurang detail dalam pembersihan sehingga saat disupervisi ditemukan area bed dan nakas tampak kotor</li> <li>Masih ditemukan troli tindakan yang terdapat bercak noda darah</li> <li>Masih ditemukan tirai/gorden di ruang perawatan yang kotor, berdebu dan di lipat diatas bed</li> <li>Masih ditemukan linen infeksius yang tergeletak dilantai</li> <li>Masih ditemukan area kamar pasien atau kamar mandi pasien yang masih kotor dan berbau</li> </ol> </li> <li>Metrik evaluasi yang digunakan,               <ol style="list-style-type: none"> <li>Audit kebersihan kamar kosong</li> <li>Audit kebersihan oleh CS</li> <li>Audit kebersihan troli tindakan</li> <li>Evaluasi kebersihan tirai/gorden</li> <li>Penanganan linen infeksius</li> <li>Evaluasi kebersihan kamar pasien dan kamar mandi</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>ACTION</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kolaborasi dengan tim umum terkait pengadaan sumber daya pembersihan lingkungan.</li> <li>Beri feedback pada hasil temuan.</li> <li>Beri teguran saat melakukan monitoring pengendalian infeksi lingkungan di unit.</li> <li>Monitoring pembersihan dan disinfeksi permukaan lingkungan yang berisiko tinggi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

- j. Kepatuhan Petugas Dalam Pengambilan Linen di Ruangan Sesuai Standart 2/3 Wadah
- Gambar 4.1.3.7 Kepatuhan Petugas Dalam Pengambilan Linen di Ruangan Sesuai Standart 2/3 Wadah



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.7 diketahui bahwa rerata kepatuhan petugas dakan pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah bulan April 2025 sebesar 89,58%.

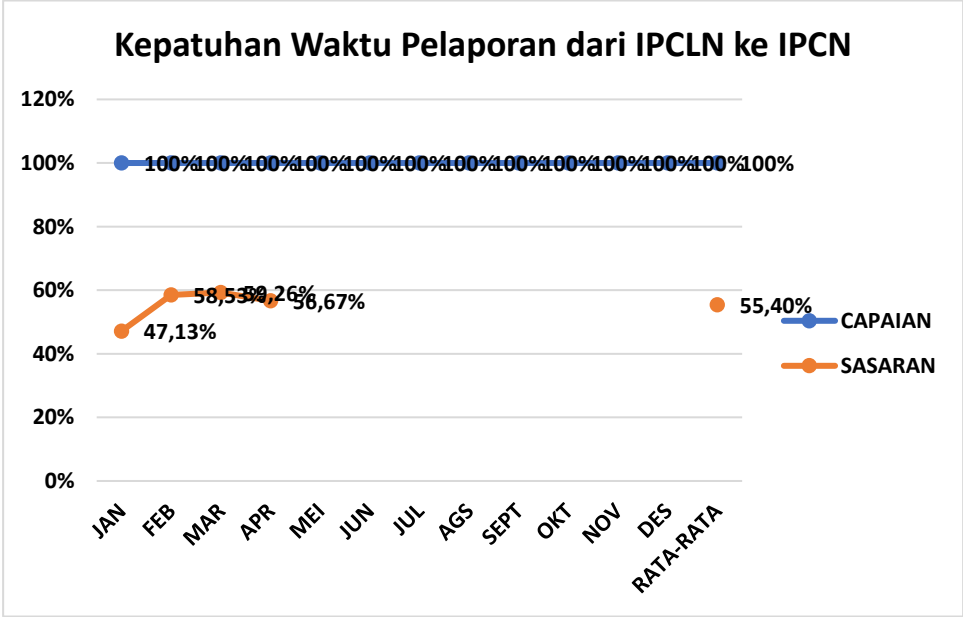
Tabel 4.1.3.8 Kepatuhan Petugas Dalam Pengambilan Linen di Ruangan Sesuai Standart 2/3 Wadah

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBLEM | Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah belum mencapai 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| STEP    | Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun linen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PLAN    | <div> <div>1. Rencana:</div> <div>Meningkatkan kepatuhan pengambilan lienn menjadi 100% sesuai standart selama 3 bulan ke depan</div> <div>2. Harapan</div> <div>Seluruh staf patuh dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah di unit laundry sehingga target kepatuhan dapat dicapai.</div> <div>3. Penyebab yang diidentifikasi;</div> <div> <div>a. Petugas belum paham resiko infeksi silang akibat overfilling</div> <div>b. Kurangnya pengawasan atau evaluasi harian</div> <div>c. Tidak tersedia alterbatif wadah bila kapasitas sudah 2/3 penuh</div> <div>d. Tidak ada system peringatan visual di wadah linen</div> </div> <div>4. Tindakan</div> <div> <div>a. Melakukan audit kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah di unit secara berkesinambungan.</div> <div>b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang</div> </div> </div> |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah.</p> <p>c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah.</p> <p>d. Berkoordinasi dengan laundry terkait temuan limbah maupun alat kesehatan pada linen kotor dan pemilahan linen di unit yang tidak sesuai 2/3 wadah</p> <p>e. Sediakan Cadangan wadah linen untuk kondisi penuh agar petugas tidak terpaksa overfill</p>                                                                                                                                                         |
| <b>DO</b>     | <p>Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah mencapai 100% di bulan berikutnya dengan upaya,</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan pelatihan secara singkat kepada petugas kebersihan dan perawat tentang penanganan linen</li><li>2. Tempel stiker batas maksimal 2/3 pada semua wadah linen kotor di setiap ruangan</li><li>3. Terapkan observasi harian oleh petugas IPCN atau kepala ruangan selama satu minggu pertama</li><li>4. Catat Tingkat kepatuhan harian dan lakukan pengingat verbal jika ditemukan pelanggaran</li></ol>                                                            |
| <b>STUDY</b>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepatuhan penanganan linen di unit belum mencapai 100%.</li><li>2. Evaluasi data observasi dan bandingkan dengan bulan sebelumnya</li><li>3. Lakukan diskusi mingguan dengan petugas terkait tantangan di lapangan</li><li>4. Catat perubahan tren kepatuhan dan identifikasi apakah penandaan visual</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ACTION</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Re-sosialisasi kepada staf terkait kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah</li><li>2. Beri feedback pada hasil temuan.</li><li>3. Beri teguran saat melakukan monitoring penanganan linen di unit, terutama pemilahan linen infeksius dan non infeksius, serta linen yang tidak terurai saat masuk di tong linen kotor.</li><li>4. Berikan system reward / sanksi sederhana berbasis performa petugas</li><li>5. Lakukan dan kaji ulang kapasitas tempat linen kotor, apabila dibutuhkan penambahan maka unit wajib melakukan SP penambahan tempat linen kotor</li></ol> |

k. Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN ke IPCN  
 Gambar 4.1.3.8 Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN ke IPCN



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.8 diketahui bahwa rerata kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN bulan April 2025 sebesar 56,67%.

Tabel 4.1.3.9 Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN ke IPCN

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBLEM | Pelaporan dari IPCLN (Petugas Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Unit) ke IPCN (Petugas PPI Rumah Sakit) tidak dilakukan tepat waktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| STEP    | Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pelaporan dan penginputan hasil serta temuan di unit terkait surveilans HAI's dan monitoring kewaspadaan isolasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PLAN    | 1. Rencana:<br>Meningkatkan kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN menjadi $\geq 90\%$ dalam 3 bulan<br>2. Harapan<br>Seluruh IPCLN dan PIC PPI unit melakukan penginputan data surveilans secara real time dan ontime sehingga target kepatuhan dapat tercapai.<br>3. Penyebab yang diidentifikasi <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak adanya jadwal pelaporan yang terstandart</li> <li>Minimnya kesadaran petugas akan pentingnya pelaporan tepat waktu</li> <li>Beban kerja IPCLN yang tinggi tanpa pengganti saat berhalangan</li> <li>Tidak adanya system pemantauan atau pengingat pelaporan</li> </ol> 4. Tindakan <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi kepada seluruh IPCLN dan PIC PPI terhadap pelaporan melalui web PPI <a href="https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo">https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo</a></li> <li>Berkolaborasi dengan kepala ruang, kepala bidan dan SDM terkait kepatuah IPCLN dan PIC PPI dalam</li> </ol> |



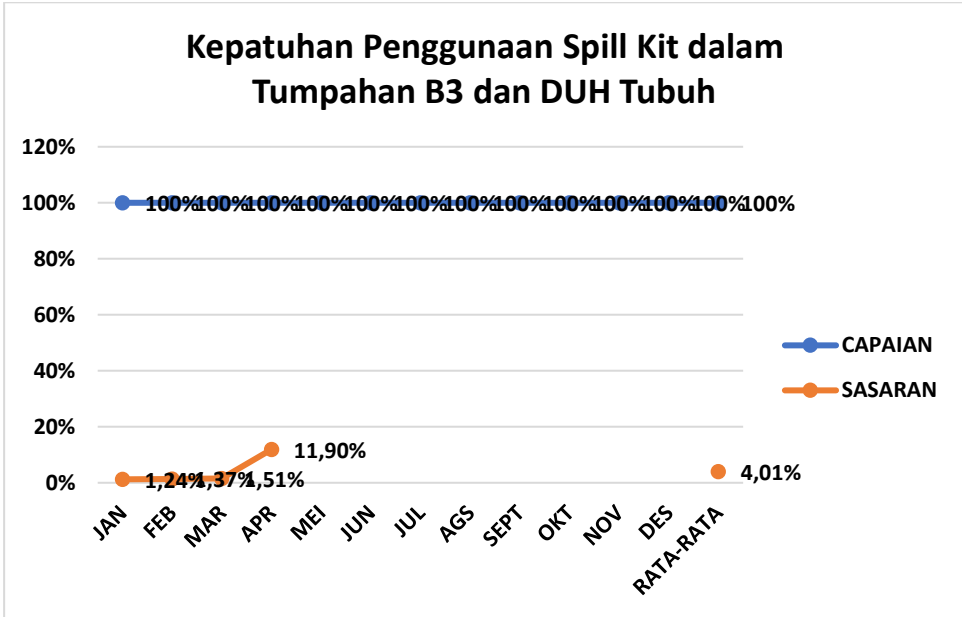
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>melakukan kepatuhan penginputan data surveilans dan monitoring kewaspadaan isolasi.</p> <p>c. Lakukan evaluasi bulanan terhadap kepatuhan pelaporan tiap unit</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DO</b>     | <p>Kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans mencapai target 100% dengan upaya,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Distribusikan SOP dan jadwal pelaporan kepada seluruh IPCLN</li> <li>2. Terapkan system pengingat via digital (Wa grub) H-1 dari jadwal pelaporan</li> <li>3. IPCLN diminta mengisi format laporan harian atau mingguan secara elektronik</li> <li>4. IPCN mencatat waktu terima laporan dari tiap unit sebagai bahan evaluasi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>STUDY</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rerata kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans di tahun 2025 di bulan April 2025 sebesar 56,67% dengan rerata 55,40% dan belum memenuhi standart 100%</li> <li>2. Bandingkan data kepatuhan sebelum dan sesudah intervensi</li> <li>3. Evaluasi kendala yang muncul selama implementasi</li> <li>4. Lakukan kuesioner singkat atau FGD dengan IPCLN untuk mendapatkan umpan balik</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ACTION</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pelatihan pengisian form PPI by web setiap bulan</li> <li>2. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kelengkapan data yang telah di isi</li> <li>3. Lakukan sosialisasi dan edukasi ulang kepada PIC PPI yang belum faha</li> <li>4. Buatkan SPO pengisian data surveilans dan monitoring kewaspadaan isolasi</li> <li>5. Lakukan audit per unit dengan identifikasi dan berikan award pada unit dengan tingkat kepatuhan tinggi dalam pelaporan</li> <li>6. Berikan feedback hasil audit dan monitoring</li> <li>7. Berikan teguran pada IPCLN dan PIC PPI yang tidak patuh dalam melakukan pelaporan</li> </ol> |

Link pelaporan dan ketepatan IPCLN dalam pelaporan ke IPCN :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jXeIYCCJSp5JRMSbAEduydwSi-AOWHlxYA8QYuDgE/edit?usp=sharing>



- I. Kepatuhan Penggunaan Spillkit dalam Tumpahan B3 dan DUH Tubuh
- Gambar 4.1.3.9 Kepatuhan Penggunaan Spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH Tubuh



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.9 diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh bulan April 2025 sebesar 11,90%.

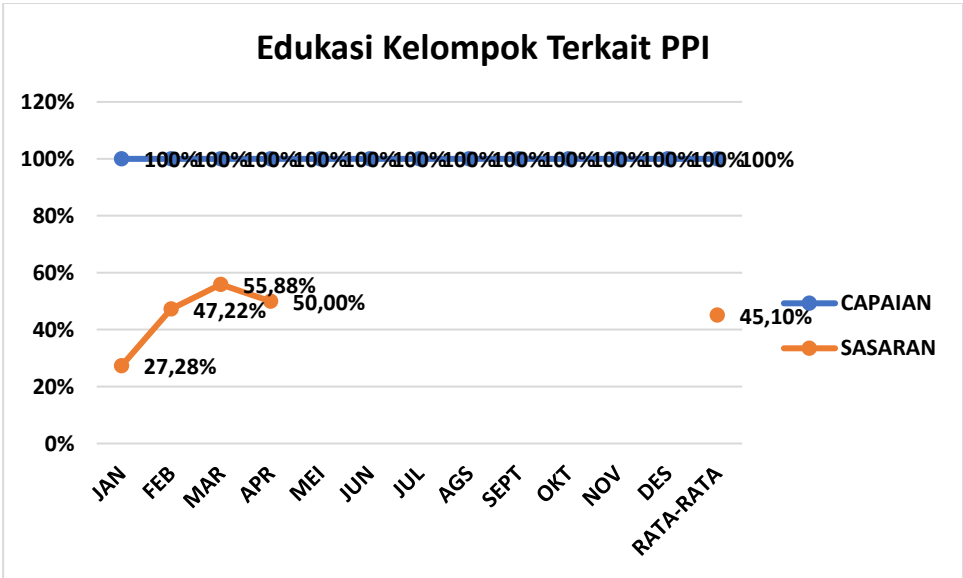
Tabel 4.1.3.10 Kepatuhan Penggunaan Spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH Tubuh

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBLEM | Petugas tidak menggunakan spill kit secara tepat saat terjadi tumpahan B3 atau darah/urine/cairan tubuh (DUH).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| STEP    | Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pelaporan dan penggunaan spillkit dalam menangani tumpahan B3 dan DUH tubuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PLAN    | <div>1. Rencana:<br/>Meningkatkan kepatuhan penggunaan spill kit dalam penanganan tumpahan B3 dan DUH tubuh menjadi ≥ 80% dalam 3 bulan.</div> <div>2. Penyebab utama<div>a. Spill tidak tersedia dilkoasi yang mudah di akses</div><div>b. Petugas belum mengetahui prosedur penggunaannya</div><div>c. Tidak ada pelatihan/praktik secara langsung</div><div>d. Tidak ada pengawasan atau audit insiden tumpahan</div></div> <div>3. Tindakan<div>a. Pastikan keberadaan spill kit diseluruh unit pelayanan beresiko</div><div>b. Sosialisasi dan pelatihan praktis penggunaan spill kit kepada seluruh petugas</div><div>c. Tempelkan alur atau poster langkah penggunaan spill kit di area strategis.</div><div>d. Bentuk tim audit untuk memantau kepatuhan dan tindak lanjut insiden.</div></div> |
| DO      | <div>1. Distribusikan spill kit ke semua unit yang membutuhkan dan pastikan kelengkapannya</div> <div>2. Laksanakan pelatihan langsung oleh IPCN/IPCLN (misalnya dengan simulasi tumpahan)</div> <div>3. Sebarkan media edukasi visual (poster, video singkat).</div> <div>4. Terapkan form pelaporan jika spill kit digunakan, untuk</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | mendokumentasikan insiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| STUDY  | 1. Data kepatuhan penggunaan spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh bulan April tahun 2025 sebesar 11,90% dengan rerata 4,01% sehingga belum mencapai standart 100%.<br>2. Evaluasi jumlah penggunaan spill kit (dari log pelaporan) dibandingkan jumlah insiden.<br>3. Lakukan survei singkat pemahaman petugas pasca pelatihan.<br>4. Identifikasi hambatan yang masih dihadapi petugas saat insiden terjadi. |
| ACTION | 1. Beri feedback hasil temuan.<br>2. Koordinasi dengan tim umum untuk selalu mengisi ulang bahan box spilkit setelah digunakan<br>3. Monitoring unit terkait kelengkapan box spilkit.<br>4. Supervisi terkait pelaporan tumpahan.<br>5. Analisis kebutuhan spill kit di unit                                                                                                                                      |

Link pelaporan tumpahan dan penggunaan spill kit :  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CV\\_mGIKtV5vjVPk4D1HuxC4sBZVbR0Li6EkPMAYpTMA/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CV_mGIKtV5vjVPk4D1HuxC4sBZVbR0Li6EkPMAYpTMA/edit?usp=sharing)

- m. Edukasi Kelompok Terkait PPI
- Gambar 4.1.3.10 Edukasi Kelompok terkait PPI



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.10 diketahui bahwa rerata kepatuhan edukasi kelompok terkait PPI bulan April 2025 sebesar 45,10%.

Tabel 4.1.4.11 Edukasi Kelompok terkait PPI

| No              | Nama Unit   | Jmlh Edukasi | Jmlh Peserta | Topik                                  | Sasaran            |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Januari</b>  |             |              |              |                                        |                    |
| 1               | IRNA 2A     | 1            | 5            | Hand hygiene                           | Pasien/pengunjung  |
| 2               | IRNA 2B     | 1            | 5            | Batuk Efektif                          | Pasien/Pengunjung  |
| 3               | IRNA 3A     | 1            | 5            | Phlebitis                              | Pasien/pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Hand hygiene                           | Pasien/pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Hand hygiene                           | Pasien/Pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Etika batuk                            | Pasien/pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Etika batuk                            | Pasien/pengunjung  |
| 4               | IRNA 3B     | 1            | 5            | Hand hygiene                           | Pasien/Pengunjung  |
| 5               | Maternitas  | 1            | 5            | Hand hygiene                           | Pasien/pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Hand hygiene                           | Pasien/pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Pencegahan Infeksi                     | Pasien/pengunjung  |
| 6               | ICU         | 1            | 5            | Hand hygiene                           | Pasien/pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Hand hygiene                           | Pasien/pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Etika Batuk                            | Pasien/pengunjung  |
| 7               | IGD         | 1            | 5            | Hand hygiene                           | Pasien/pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Hand hygiene                           | Pasien/pengunjung  |
| 8               | RM/PDF      | 1            | 8            | Hand hygiene                           | Staff              |
| 9               | IKO         | 1            | 3            | Pencegahan Infeksi pada pasien post op | Pencegahan Infeksi |
| <b>Februari</b> |             |              |              |                                        |                    |
| 1               | IRNA 2A     | 1            | 5            | Batuk Efektif                          | Pasien/pengunjung  |
| 2               | IRNA 2B     | 1            | 5            | Batuk Efektif                          | Pasien/Pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Phlebitis                              | Pasien/pengunjung  |
| 3               | IRNA 3A     | 1            | 5            | Batuk Efektif                          | Pasien/pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Pemilahan Sampah                       | Pasien/pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Batuk Efektif                          | Pasien/pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Phlebitis                              | Pasien/pengunjung  |
| 4               | IRNA 3B     | 1            | 5            | Cuci tangan                            | Pasien/pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Cuci tangan                            | Pasien/pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Batuk efektif                          | Pasien/pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Cuci tangan                            | Pasien/Pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Batuk efektif                          | Pasien/pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Batuk efektif                          | Pasien/pengunjung  |
| 5               | ICU         | 1            | 5            | Cuci tangan                            | Pasien/pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Batuk efektif                          | Pasien/pengunjung  |
| 6               | IGD         | 1            | 5            | Cuci tangan                            | Pasien/pengunjung  |
|                 |             | 1            | 6            | Batuk efektif                          | Pasien/pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Cuci tangan                            | Pasien/pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Phlebitis                              | Pasien/pengunjung  |
| 7               | IRJA        | 1            | 5            | Cuci tangan                            | Pasien/Pengunjung  |
| 8               | Maternitas  | 1            | 5            | Cuci tangan                            | Pasien/pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Cuci tangan                            | Pasien/pengunjung  |
|                 |             | 1            | 5            | Pencegahan infeksi                     | Pasien/pengunjung  |
| 9               | Neonatologi | 1            | 5            | Cuci tangan                            | Pasien/pengunjung  |

|       |             |   |   |                     |                   |
|-------|-------------|---|---|---------------------|-------------------|
|       |             | 1 | 5 | Cuci tangan         | Pasien/pengunjung |
| 10    | RM/PDF      | 1 | 8 | Cuci tangan         | Staff             |
| Maret |             |   |   |                     |                   |
| 1     | IRNA 2A     | 1 | 5 | Cuci tangan         | Pasien/pengunjung |
|       |             | 2 | 5 | Etika Batuk         | Pasien/Pengunjung |
|       |             | 2 | 5 | Plebitis            | Pasien/pengunjung |
| 2     | IRNA 2B     | 1 | 5 | Cuci tangan         | Pasien/pengunjung |
|       |             | 1 | 5 | Etika Batuk         | Pasien/pengunjung |
| 3     | IRNA 3A     | 3 | 5 | Cuci tangan         | Pasien/Pengunjung |
|       |             | 1 | 5 | Plebitis            | Pasien/pengunjung |
|       |             | 1 | 5 | Etika Batuk         | Pasien/pengunjung |
| 4     | IRNA 3B     | 3 | 5 | Cuci tangan         | Pasien/pengunjung |
|       |             | 1 | 5 | Etika batuk         | Pasien/Pengunjung |
| 5     | Maternitas  | 1 | 5 | Pencegahan<br>IDO   | Pasien/pengunjung |
|       |             | 1 | 5 | Cuci tangan         | Pasien/pengunjung |
| 6     | Neonatologi | 2 | 5 | Cuci tangan         | Pasien/pengunjung |
| 7     | IGD         | 1 | 8 | Cuci tangan         | Pasien/Pengunjung |
|       |             | 1 | 8 | Etika Batuk         | Pasien/pengunjung |
| 8     | ICU         | 2 | 8 | Cuci tangan         | Pasien/pengunjung |
| 9     | Radiologi   | 1 | 6 | Pemilahan<br>sampah | Pasien/pengunjung |
| 10    | IRJA        | 1 | 2 | Cuci tangan         | Pasien/pengunjung |
| April |             |   |   |                     |                   |
| 1     | IRNA 3A     | 3 | 5 | Cuci tangan         | Pasien/Pengunjung |
|       |             | 1 | 5 | Etika Batuk         | Pasien/pengunjung |
|       |             | 2 | 5 | Plebitis            | Pasien/pengunjung |
|       |             | 1 | 5 | Pencegahan<br>IDO   | Pasien/pengunjung |
| 2     | IRNA 3B     | 1 | 5 | Cuci Tangan         | Pasien/pengunjung |
|       |             | 1 | 5 | Etika Batuk         | Pasien/Pengunjung |
|       |             | 1 | 5 | Pencegahan<br>IDO   | Pasien/pengunjung |
| 3     | IRNA 2A     | 1 | 5 | Batuk efektif       | Pasien/pengunjung |
|       |             | 1 | 5 | Plebitis            | Pasien/pengunjung |
|       |             | 1 | 5 | Pencegahan<br>IDO   | Pasien/pengunjung |
| 4     | IRNA 2B     | 1 | 5 | Cuci tangan         | Pasien/Pengunjung |
|       |             | 1 | 5 | Etika Batuk         | Pasien/pengunjung |
| 5     | MATERNITAS  | 1 | 5 | Cuci tangan         | Pasien/pengunjung |
|       |             | 1 | 5 | Pencegahan<br>IDO   | Pasien/pengunjung |
| 6     | NEONATOLOGI | 3 | 5 | Cuci tangan         | Pasien/pengunjung |
|       |             | 1 | 5 | Pemilahan<br>sampah | Pasien/Pengunjung |
| 7     | ICU         | 3 | 5 | Cuci tangan         | Pasien/pengunjung |
|       |             | 2 | 5 | Etika batuk         | Pasien/pengunjung |
| 8     | RM          | 2 | 8 | Cuci tangan         | Staff unit        |
| 9     | IGD         | 1 | 8 | Cuci tangan         | Pasien/pengunjung |
|       |             | 2 | 8 | Etika batuk         | Pasien/pengunjung |
| Mei   |             |   |   |                     |                   |
|       |             |   |   |                     |                   |

Tabel 4.1.4.12 Edukasi Kelompok terkait PPI

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLAN</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masalah<br/>Edukasi kelompok terkait PPI belum dilaksanakan secara rutin atau terdokumentasi dengan baik.</li> <li>2. Tujuan<br/>Meningkatkan kepatuhan pelaksanaan dan dokumentasi edukasi kelompok PPI <math>\geq 80\%</math> dalam 3 bulan</li> <li>3. Analisa masalah <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jadwal edukasi tidak tersusun dengan sistematis.</li> <li>b. Petugas tidak memiliki materi edukasi standar.</li> <li>c. Dokumentasi edukasi sering terlewatkan.</li> <li>d. Kurangnya koordinasi antar unit dengan IPCN/IPCLN.</li> </ol> </li> <li>4. Strategi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Susun jadwal edukasi mingguan/bulanan di setiap unit.</li> <li>b. Sediakan materi edukasi PPI yang mudah dipahami pasien/keluarga.</li> <li>c. Buat form standar dokumentasi edukasi (manual/digital).</li> <li>d. Tetapkan PIC edukasi di tiap unit pelayanan.</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>DO</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laksanakan pelatihan kepada petugas terkait metode edukasi efektif dan SOP dokumentasi.</li> <li>2. Distribusikan materi edukasi PPI berupa leaflet, poster, dan video edukatif.</li> <li>3. Implementasikan sistem pelaporan edukasi harian/pekanan.</li> <li>4. IPCN/IPCLN melakukan monitoring dan pendampingan awal.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>STUDY</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi jumlah edukasi yang berhasil dilaksanakan dan terdokumentasi.</li> <li>2. Ambil umpan balik dari pasien/keluarga mengenai pemahaman edukasi yang diberikan.</li> <li>3. Identifikasi unit yang belum mencapai target dan hambatannya</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ACTION</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beri feedback akan adanya kendala dalam melakukan edukasi kelompok atau individu</li> <li>2. Koordinasi dengan IPCLN untuk melakukan penjadwalan edukasi kelompok atau individu</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi unit terkait kepatuhan edukasi melalui link edukasi .</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

4.2

Kesehatan karyawan

Tabel 4.2. Data Kesehatan Karyawan

| No | Bulan    | Jumlah Staf yang MCU | Jenis Pemeriksaan |        |       |     | Keterangan                                                                                            | Hasil Pemeriksaan |
|----|----------|----------------------|-------------------|--------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |          |                      | Fisik             | Thorax | HbsAg | HIV |                                                                                                       |                   |
| 1. | Januari  | -                    | -                 | -      | -     | -   | -                                                                                                     | -                 |
| 2. | Februari | -                    | -                 | -      | -     | -   | -                                                                                                     | -                 |
| 3. | Maret    | 467                  | 206               | -      | -     | -   |                                                                                                       |                   |
| 4. | April    | 467                  | 225               | -      | -     | -   | Ada penambahan 19 staff yang melakukan MCU<br><br>Total staff yang belum melaksanakan MCU : 242 staff |                   |
| 5. |          |                      |                   |        |       |     |                                                                                                       |                   |

Interpretasi : Pada tabel 4.2 terkait data kesehatan karyawan terdapat kegiatan MCU staff pada bulan April 2025 sebanyak 19 staff.

Tabel 4.2.1 Data Kesehatan Karyawan

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAN  | <div> 1. Masalah<br/>Sebagian staf belum melaksanakan pemeriksaan MCU (Medical Check-Up). Dari total target, masih ada 242 staf yang belum menjalani MCU.<br/> 2. Tujuan<br/>Meningkatkan jumlah staf yang melaksanakan MCU secara menyeluruh dan memastikan semua komponen pemeriksaan (fisik, thorax, HBsAg, HIV) dilakukan.<br/> 3. Strategi<br/> a. Identifikasi staff yang belum menjalani MCU<br/> b. Koordinasi dengan tim kesehatan untuk jadwal pemeriksaan lanjutan<br/> c. Sosialisasi kepada staff mengenai pentingnya MCU dan pemeriksaan menyeluruh </div> |
| DO    | <div> 5. Laksanakan pelatihan kepada petugas terkait metode edukasi efektif dan SOP dokumentasi.<br/> 6. Distribusikan materi edukasi PPI berupa leaflet, poster, dan video edukatif.<br/> 7. Implementasikan sistem pelaporan edukasi harian/pekanan.<br/> 8. IPCN/IPCLN melakukan monitoring dan pendampingan awal. </div>                                                                                                                                                                                                                                             |
| STUDY | <div> 4. Evaluasi jumlah edukasi yang berhasil dilaksanakan dan terdokumentasi.<br/> 5. Ambil umpan balik dari pasien/keluarga mengenai pemahaman edukasi yang diberikan.<br/> 6. Identifikasi unit yang belum mencapai target dan hambatannya </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTION</b> | <div>4. Beri feedback akan adanya kendala dalam melakukan edukasi kelompok atau individu</div> <div>5. Koordinasi dengan IPCLN untuk melakukan penjadwalan edukasi kelompok atau individu</div> <div>6. Monitoring dan evaluasi unit terkait kepatuhan edukasi melalui link edukasi .</div> |
| <b>PLAN</b>   | Meningkatkan kepatuhan staff dalam melakukan kegiatan MCU yang bertujuan untuk skrining utama terhadap rantai infeksi yang terjadi pada tenaga kesehatan                                                                                                                                    |
| <b>DO</b>     | Monitoring kepatuhan staff dalam melakukan MCU karyawan yang dilakukan secara terjadwal                                                                                                                                                                                                     |
| <b>STUDY</b>  | Rerata kepatuhan Kesehatan karyawan bulan Maret 0 dikarenakan tidak ada agenda MCU staff dari SDM.                                                                                                                                                                                          |
| <b>ACTION</b> | <div>1. Koordinasi dengan SDM untuk penjadwalan MCU staff</div> <div>2. Beri feedback akan adanya temuan hasil dari MCU staff</div> <div>3. Monitoring dan evaluasi kegiatan MCU staff secara berkesinambungan.</div>                                                                       |

---

## BAB V.

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kinerja komite PPI pada tahun 2025 didapatkan masih ditemukan banyaknya penilaian yang tidak mencapai target dan masih ditemukan beberapa masalah seperti,

- a. Kepatuhan petugas dalam melakukan *hand hygien*,
- b. Kepatuhan petugas dalam penggunaan APD,
- c. Kepatuhan penyuntikan,
- d. Kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan,
- e. Kepatuhan penanganan limbah,
- f. Kepatuhan penanganan pembuangan jarum dan benda tajam,
- g. Kepatuhan penanganan tumpahan darah,
- h. Kepatuhan pelayanan makanan,
- i. Kejadian phlebitis dalam 2025,
- j. Ketidakpatuhan petugas dalam melakukan pelaporan dan pengisian di web komite PPI 2025

#### 5.2 Saran

Dari hasil penulisan dan pelaporan tahunan Komite PPI 2025 diharapkan adanya perbaikan yang dapat dilakukan oleh semua unit dalam proses pelaporan dan penugasan dari Komite PPI terkait,

- a. Pengambilan data di unit oleh IPCLN/PIC PPI Unit terkait audit bundle HAI's, pelaporan HAI's, monitoring dan supervisi, sosialis PPI kepada pasien/keluarga/pengunjung pasien,
- b. Evaluasi dalam berjalannya ICRA Program di unit yang berhubungan dengan Bundle HAI's.



**BAB VI.**  
**PENUTUP**

Demikian laporan bulan Maret tahun 2025 Komite PPI disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Sukorejo tahun 2025. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang perbaikan pelayanan di tahun berikutnya.

Pasuruan, 08 Mei 2025

Mengetahui,  
Ketua Komite PPIRS



**Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP**

IPCN



**Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep., Ns.**

Menyetujui,  
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



**dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS.**

Lampiran :

1. Link Supervisi PPI 2025 :  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JO8PKQG1PkET\\_U3IODHmUxZfTRMy1JLkgvpPPzQRRRA/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JO8PKQG1PkET_U3IODHmUxZfTRMy1JLkgvpPPzQRRRA/edit?usp=sharing)
2. Link Rekap PPI 2025 :  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pf750mUyrg4oJueUUI58h-qF3exSXqQd/edit?usp=sharing&ouid=112068003789464975539&rtpof=true&sd=true>